일반교육·전문교육 현지교육 교안

한국어 + 베트남어 | 23개 과목 | 2026-09-17

총 280시간: 한국어 160시간 + 일반교육 48시간 + 전문교육 72시간. 감염관리·환자안전 각 8시간은 일반교육에 포함합니다. 직무 강의는 준비·돌봄 순서·상태별 대응·주의사항·보고를 다룹니다. 의료진·실습강사 검토용 초안이며 실제 업무 범위를 허가하거나 전체 감독 실습을 대신하지 않습니다.

한국어 목표: TOPIK II 3급 이상. 듣기·읽기·쓰기 시험 준비와 병원 회화 실습을 병행합니다. 입문자의 160시간 수강만으로 3급 취득을 보장하지 않으며, 진단평가 후 부족한 영역은 보충합니다.

교육 편성

한국어 160시간: 병원 의사소통과 TOPIK II 3급 이상 목표 학습.

직무 일반교육 48시간: 돌봄 원칙, 기저귀·배설, 식사, 샤워·목욕, 이동·체위, 감염관리, 환자안전.

전문교육 72시간: 경관영양, 유치도뇨관, 폐질환, 치매, 뇌질환, 파킨슨, 당뇨, 투석, 암, 호스피스 환자 돌봄.

교육 순서·평가

일반교육의 안전 수행을 먼저 확인한 뒤 전문교육을 진행합니다. 강사가 개별 계획 확인, 동의, 안전한 지원, 이상 관찰과 보고를 평가하고, 부족한 항목은 보충 실습 후 재평가합니다. 실제 배치 전 해당 병원 업무 지침과 역할을 다시 확인합니다.

피딩은 경관영양, 소변줄은 유치도뇨관으로 해석해 편성했습니다. 시간 배분은 운영 검토용이며 기존 수강 기록을 소급 변경하지 않습니다.

과목과 출력 쪽 안내

과목별로 교안, 관찰·기록·보고, 한국어 원고와 베트남어 번역이 이어집니다. 표의 쪽 범위를 선택해 출력하세요.

과목	시간	쪽
01. 인사말과 기본 표현	24	3-5
02. 자기소개	24	6-8
03. 병원 용어 기초	24	9-11
04. 환자와의 대화	24	12-14
05. 어휘 정리 자료	24	15-17
06. TOPIK II 3급 목표 학습	40	18-20
G01. 돌봄 기본원칙·직업윤리·보고	4	21-29
G02. 기저귀 사용 환자·배설·피부 돌봄	8	30-37
G03. 식사돌봄·수분·구강 위생	8	38-45
G04. 샤워·목욕·세면·청결 돌봄	8	46-50
G05. 이동·체위·침상·생활환경 지원	4	51-55
G06. 감염관리·손 위생·보호구	8	56-60
G07. 환자안전·낙상·피부손상·비상보고	8	61-65
S01. 피딩 환자: 경관영양 돌봄	10	66-73
S02. 소변줄 환자: 유치도뇨관 돌봄	6	74-81
S03. 폐질환 환자·호흡 불편 돌봄	6	82-90
S04. 치매 환자·인지·행동 변화 돌봄	8	91-95
S05. 뇌질환 환자·뇌졸중 후 돌봄	8	96-100
S06. 파킨슨 환자·움직임·생활 지원	6	101-105
S07. 당뇨 환자·식사·피부·이상 징후	6	106-110
S08. 투석 환자·이동·치료 전후 돌봄	6	111-119
S09. 암 환자: 간암·뇌암·췌장암·대장암·폐암 등	10	120-126
S10. 호스피스 환자·완화적 돌봄·가족 지원	6	127-131

01. 인사말과 기본 표현

한국어 | 계획 24시간 | 교안

설명·시연 8시간 / 연습·실습 14시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 이름·병실·시간을 듣고 다시 확인한다.

- 환자에게 존댓말로 인사하고 도움을 제안한다.

준비물: 한글·숫자 카드, 병실 안내판, 시계 그림, 역할 카드

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 간병인과 환자 역할을 바꿉니다. 인사 → 이름 확인 → 필요한 도움 묻기 → 답변 재확인 순서로 연습합니다. 숫자·시간 받아쓰기를 반복하고 오해한 표현을 고쳐 말합니다.

확인 문제와 해설

환자가 말한 시간을 잘 못 들었을 때 어떻게 확인할까요?

해설: '죄송합니다. 다시 말씀해 주시겠어요? 오전 아홉 시가 맞습니까?'처럼 정중하게 다시 확인합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

01. 인사말과 기본 표현

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

이번 수업은 인사말과 기본 표현입니다. 목표는 말을 빠르게 하는 것이 아니라 상대방의 뜻을 정확하게 확인하는 것입니다. 먼저 '안녕하세요. 저는 오늘 도움을 드릴 간병인입니다.'라고 인사해 보세요. 이름과 맡은 역할을 천천히 말합니다.

02 / 강의 원고

환자에게 바로 손을 대기 전에 '도와드려도 될까요?'라고 묻습니다. 대답을 충분히 기다리고, 싫다고 하면 이유를 듣고 담당자에게 알립니다. '괜찮으세요?'와 '무엇이 필요하세요?'는 서로 다른 질문입니다. 예 또는 아니오로 확인할 때와 자세한 요구를 들을 때를 구분해 봅니다.

03 / 강의 원고

병실 번호와 시간을 들은 뒤에는 다시 말해 확인합니다. '삼 층 삼백이 호가 맞습니까?' '오전 아홉 시입니까?'라고 묻습니다. 모르는 말을 알아들은 척하지 마세요. '다시 말씀해 주시겠어요?'라는 표현을 함께 연습합니다.

04 / 강의 원고

짝과 역할을 바꾸어 인사하고, 도움을 묻고, 시간을 확인하세요. 강사는 존댓말, 발음, 확인 질문을 관찰합니다. 오늘의 확인 문제입니다. 잘 듣지 못했다면 추측해서 행동할까요? 아닙니다. 다시 묻고 확인한 뒤 행동합니다.

학습 메모

_____

_____

01. 인사말과 기본 표현

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Bài học này nói về lời chào và các cách diễn đạt cơ bản. Mục tiêu không phải nói thật nhanh, mà là xác nhận đúng ý của người đối thoại. Trước tiên, hãy chào bằng câu tiếng Hàn: ‘Xin chào. Tôi là người chăm sóc sẽ hỗ trợ ông/bà hôm nay.’ Hãy nói chậm tên và vai trò của mình.

02

Trước khi chạm vào người bệnh, hãy hỏi: ‘Tôi có thể giúp ông/bà được không?’ Chờ câu trả lời; nếu họ từ chối, hãy lắng nghe lý do và báo người phụ trách. ‘Ông/bà có ổn không?’ khác với ‘Ông/bà cần gì?’ Hãy phân biệt câu hỏi xác nhận có hoặc không với câu hỏi tìm hiểu nhu cầu cụ thể.

03

Sau khi nghe số phòng và giờ, hãy nhắc lại để xác nhận. Có thể hỏi: ‘Có phải phòng 302 ở tầng ba không?’ hoặc ‘Có phải chín giờ sáng không?’ Đừng giả vờ hiểu từ mình chưa biết. Hãy cùng luyện câu: ‘Ông/bà có thể nói lại được không?’

04

Hãy đổi vai với bạn học để chào hỏi, đề nghị giúp đỡ và xác nhận thời gian. Giảng viên quan sát kính ngữ, phát âm và câu hỏi xác nhận. Câu hỏi ôn tập: Nếu nghe không rõ thì có nên đoán rồi hành động không? Không; hãy hỏi lại và xác nhận trước khi làm.

02. 자기소개

한국어 | 계획 24시간 | 교안

설명·시연 8시간 / 연습·실습 14시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 이름·출신·경험·지원 동기를 순서대로 말한다.

- 모르는 질문에 재설명을 요청한다.

준비물: 자기소개 작성지, 면접 질문 카드, 녹음 도구

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

4문장 자기소개를 작성하고 1분 발표를 녹음합니다. 동료가 들은 사실을 적어 원문과 비교합니다. 면접관과 지원자 역할을 교대하며 질문에 한 문장씩 답합니다.

확인 문제와 해설

경험이 없는 업무에 대해 질문받으면 어떻게 답할까요?

해설: 경험이 없음을 사실대로 말하고 감독 아래 교육받을 필요를 설명합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

02. 자기소개

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

자기소개는 사실을 알기 쉽게 전달하는 연습입니다. '안녕하세요. 제 이름은 응우옌 안입니다. 베트남에서 왔습니다.'처럼 이름과 출신을 말합니다. 이 이름은 연습용입니다. 실제 지원서에는 본인의 정확한 이름을 사용합니다.

02 / 강의 원고

다음으로 실제 경험을 이야기합니다. '가족의 식사를 도운 경험이 있습니다.'처럼 무엇을 했는지 구체적으로 말하세요. 자격증이나 경력을 가지고 있지 않다면 있다고 말하지 않습니다. 할 수 있는 일과 교육이 필요한 일을 구분하는 것도 중요한 의사소통입니다.

03 / 강의 원고

지원 동기는 짧게 말합니다. '환자를 존중하면서 안전하게 돕고 싶습니다.'라고 말한 뒤 배우고 싶은 내용을 덧붙입니다. 면접 질문을 이해하지 못하면 '질문을 조금 쉽게 말씀해 주시겠어요?'라고 요청합니다. 통역이 필요하다는 표현도 연습합니다.

04 / 강의 원고

이제 이름, 출신, 경험, 배우고 싶은 내용으로 네 문장을 작성해 보세요. 짝이 들은 내용과 본인이 쓴 내용이 같은지 확인합니다. 강사는 화려한 표현보다 사실 전달과 질문 이해 여부를 확인합니다.

학습 메모

_____

_____

02. 자기소개

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Tự giới thiệu là luyện cách truyền đạt sự thật dễ hiểu. Hãy nói tên và quê quán, chẳng hạn: ‘Xin chào. Tôi tên là Nguyễn An. Tôi đến từ Việt Nam.’ Đây là tên dùng để luyện tập. Trong hồ sơ thật, hãy dùng đúng tên của mình.

02

Tiếp theo, hãy nói về kinh nghiệm thực tế. Nêu rõ việc mình đã làm, chẳng hạn: ‘Tôi từng giúp người nhà trong bữa ăn.’ Không nói mình có chứng chỉ hoặc kinh nghiệm nếu chưa có. Phân biệt việc mình làm được với việc cần được đào tạo cũng là kỹ năng giao tiếp quan trọng.

03

Hãy trình bày ngắn gọn lý do ứng tuyển. Có thể nói: ‘Tôi muốn hỗ trợ người bệnh an toàn và tôn trọng họ’, rồi nêu điều mình muốn học. Nếu không hiểu câu hỏi phỏng vấn, hãy đề nghị: ‘Xin vui lòng nói câu hỏi đơn giản hơn.’ Cũng cần luyện cách yêu cầu phiên dịch.

04

Bây giờ hãy viết bốn câu về tên, quê quán, kinh nghiệm và điều muốn học. So sánh điều bạn học nghe được với nội dung mình đã viết. Giảng viên kiểm tra khả năng truyền đạt sự thật và hiểu câu hỏi, thay vì chỉ đánh giá cách nói hoa mỹ.

03. 병원 용어 기초

한국어 | 계획 24시간 | 교안

설명·시연 8시간 / 연습·실습 14시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 병원 공간·신체·일상지원 어휘를 구분한다.

- 지시의 대상·시간·내용을 재확인한다.

준비물: 병원 공간 사진, 신체 그림, 어휘 카드, 모의 지시문

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

장소·물품·신체 어휘를 분류하고 그림과 연결합니다. 짧은 지시문을 듣고 대상·시간·내용을 표에 적은 뒤 되묻기를 연습합니다.

확인 문제와 해설

알지 못하는 약 이름을 들으면 임의로 판단해도 될까요?

해설: 아니요. 담당 간호사에게 정확히 확인하고 자신의 허용 업무 범위를 지킵니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

03. 병원 용어 기초

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

병원 용어를 배울 때는 뜻과 사용 장소를 함께 익힙니다. 병실, 간호사실, 화장실, 식당처럼 공간을 가리키는 말부터 확인하세요. 침대, 휠체어, 호출벨은 물품 이름입니다. 사진을 보면서 이름과 위치를 말해 봅니다.

02 / 강의 원고

신체와 불편함을 표현하는 말도 필요합니다. '머리가 아파요.' '어지러워요.'처럼 환자의 말을 듣는 연습을 합니다. 간병인은 이 말을 듣고 병명을 정하는 것이 아니라, 들은 말과 관찰한 사실을 담당자에게 전달합니다.

03 / 강의 원고

지시는 대상, 시간, 내용을 나누어 확인합니다. '누구를 도와야 합니까?' '언제입니까?' '어떤 도움입니까?'를 확인하세요. 생소한 약이나 처치에 관한 말을 듣고 임의로 행동하지 않습니다. 담당 간호사에게 확인하고 맡은 업무 범위를 지킵니다.

04 / 강의 원고

연습에서는 짧은 지시문을 듣고 표의 세 칸을 채웁니다. 빈칸이 있으면 다시 질문합니다. 어휘를 많이 외우는 것과 정확하게 이해하는 것은 다릅니다. 모르는 표현을 표시하고 다시 확인하는 습관을 만드세요.

학습 메모

_____

_____

03. 병원 용어 기초

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Khi học thuật ngữ bệnh viện, hãy học cả ý nghĩa lẫn nơi sử dụng. Trước hết, xác nhận các từ chỉ địa điểm như phòng bệnh, phòng điều dưỡng, nhà vệ sinh và nhà ăn. Giường, xe lăn và chuông gọi là tên đồ dùng. Hãy nhìn ảnh rồi nói tên và vị trí.

02

Cũng cần biết từ ngữ về cơ thể và cảm giác khó chịu. Luyện nghe người bệnh nói như ‘Tôi đau đầu’ hoặc ‘Tôi chóng mặt.’ Người chăm sóc không tự chẩn đoán từ những lời này, mà chuyển lời đã nghe và sự việc quan sát được cho người phụ trách.

03

Khi nhận chỉ dẫn, hãy xác nhận riêng đối tượng, thời gian và nội dung. Hỏi: ‘Tôi cần giúp ai?’, ‘Khi nào?’ và ‘Giúp việc gì?’ Không tự hành động khi nghe tên thuốc hoặc thủ thuật chưa biết. Hãy xác nhận với điều dưỡng phụ trách và giữ đúng phạm vi công việc.

04

Trong bài tập, nghe một chỉ dẫn ngắn và điền ba ô tương ứng. Nếu còn ô trống, hãy hỏi lại. Thuộc nhiều từ khác với hiểu chính xác. Hãy tạo thói quen đánh dấu cách diễn đạt chưa biết và xác nhận lại.

04. 환자와의 대화

한국어 | 계획 24시간 | 교안

설명·시연 6시간 / 연습·실습 16시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 환자의 요청을 듣고 동의를 확인한다.

- 관찰 사실과 환자의 말을 구분해 보고한다.

준비물: 요청·거절 상황 카드, 보고 양식, 통역 요청 예시

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

식사 도움·이동 요청·도움 거절 상황을 역할극으로 연습합니다. 환자 역할이 말한 내용을 다른 조원이 듣고 보고서와 비교합니다.

확인 문제와 해설

'아파요'라는 말을 들었을 때 보고에 무엇을 넣을까요?

해설: 시간·장소·환자가 한 말·직접 관찰한 사실을 전달하고 담당자의 지시를 확인합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

04. 환자와의 대화

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

환자와 대화할 때는 한 번에 한 가지를 짧게 질문합니다. '물을 드릴까요?'라고 물은 뒤 답을 기다립니다. 식사나 수분 제공은 먼저 병원의 개별 지시사항을 확인해야 합니다. 말이 느리다고 해서 이해 능력을 단정하지 않습니다.

02 / 강의 원고

환자가 도움을 거절하면 억지로 진행하지 않습니다. '불편한 점이 있으세요?'라고 묻고, 필요한 경우 담당자에게 알립니다. 사생활과 선택을 존중하면서 안전에 영향을 주는 상황을 놓치지 않는 것이 중요합니다.

03 / 강의 원고

보고할 때는 사실과 추측을 나눕니다. '열 시에 환자가 어지럽다고 말씀하셨습니다.'는 들은 사실입니다. 원인을 마음대로 정해서 보고하지 않습니다. 상황이 급하면 긴 문장을 완성하려고 기다리지 말고 병원 연락체계에 따라 즉시 도움을 요청합니다.

04 / 강의 원고

의사소통이 어려우면 통역을 요청합니다. 번역 앱을 쓸 때는 병원 방침을 확인하고 이름이나 민감한 정보를 무심코 입력하지 않습니다. 오늘은 요청 듣기, 동의 확인, 담당자 보고를 세 단계로 연습합니다.

학습 메모

_____

_____

04. 환자와의 대화

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Khi nói chuyện với người bệnh, hãy hỏi ngắn gọn từng việc một. Ví dụ, hỏi ‘Ông/bà có muốn uống nước không?’ rồi chờ câu trả lời. Trước khi hỗ trợ ăn uống, phải kiểm tra chỉ dẫn riêng của bệnh viện cho người đó. Không suy đoán khả năng hiểu chỉ vì họ nói chậm.

02

Nếu người bệnh từ chối giúp đỡ, không ép buộc. Hỏi ‘Có điều gì làm ông/bà khó chịu không?’ và báo người phụ trách khi cần. Điều quan trọng là tôn trọng đời tư và lựa chọn, đồng thời không bỏ sót tình huống ảnh hưởng đến an toàn.

03

Khi báo cáo, hãy tách sự thật khỏi suy đoán. ‘Lúc mười giờ, người bệnh nói bị chóng mặt’ là điều đã nghe. Không tự quyết định nguyên nhân để báo cáo. Nếu khẩn cấp, đừng chờ soạn câu dài hoàn chỉnh; hãy yêu cầu trợ giúp ngay theo hệ thống liên lạc của bệnh viện.

04

Nếu giao tiếp khó khăn, hãy yêu cầu phiên dịch. Khi dùng ứng dụng dịch, kiểm tra quy định bệnh viện và không tùy tiện nhập tên hay thông tin nhạy cảm. Hôm nay luyện ba bước: nghe yêu cầu, xác nhận sự đồng ý và báo người phụ trách.

05. 어휘 정리 자료

한국어 | 계획 24시간 | 교안

설명·시연 6시간 / 연습·실습 16시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 한·베 어휘장을 만들고 예문으로 활용한다.

- 생활·기숙사·근무 일정 표현을 이해한다.

준비물: 한국어기초사전 베트남어판, 개인 어휘장, 근무표 예시

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

생활·병원·기숙사 어휘를 분류해 뜻과 예문을 작성합니다. 일주일 간격으로 복습하고 근무표·안내문에서 실제 표현을 찾아 설명합니다.

확인 문제와 해설

단어의 번역만 외우는 것보다 무엇을 함께 기록하면 좋을까요?

해설: 사용 상황, 짧은 예문, 발음과 확인이 필요한 뜻을 함께 적습니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

05. 어휘 정리 자료

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

어휘장은 한국어 단어와 베트남어 뜻을 나란히 적는 데서 시작합니다. 여기에 실제로 쓸 문장을 한 개 더 적으세요. '교대'라는 단어를 배우면 '교대 시간은 언제입니까?'라는 질문을 함께 연습합니다.

02 / 강의 원고

단어는 생활, 병원, 기숙사로 나누어 정리합니다. 생활에서는 교통과 식사, 병원에서는 물품과 보고, 기숙사에서는 청소와 공동생활 표현을 다룹니다. 한국어기초사전 베트남어판을 참고하되 뜻이 여러 개면 문맥을 확인합니다.

03 / 강의 원고

근무표와 안내문을 읽는 연습도 합니다. 날짜, 시작 시간, 장소, 준비물을 표시하세요. 이해하지 못한 부분은 담당자에게 질문합니다. 다른 사람의 근무표나 개인정보가 있는 문서를 허락 없이 공유하지 않습니다.

04 / 강의 원고

복습은 단어를 다시 읽는 것에서 끝내지 않습니다. 뜻을 가리고 말해 보고, 예문을 만들고, 짝에게 설명합니다. 자주 틀린 표현을 따로 표시해 다음 수업에서 질문하세요. 오늘의 결과물은 실제 생활에서 사용할 수 있는 개인 어휘장입니다.

학습 메모

_____

_____

05. 어휘 정리 자료

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Sổ từ vựng bắt đầu bằng việc ghi từ tiếng Hàn bên cạnh nghĩa tiếng Việt. Sau đó thêm một câu thật sự có thể sử dụng. Khi học từ ‘đổi ca’, hãy luyện cả câu hỏi: ‘Giờ đổi ca là khi nào?’

02

Chia từ vựng thành sinh hoạt, bệnh viện và ký túc xá. Phần sinh hoạt gồm giao thông và ăn uống; bệnh viện gồm đồ dùng và báo cáo; ký túc xá gồm vệ sinh và sống chung. Có thể tham khảo Từ điển tiếng Hàn cơ sở bản tiếng Việt, nhưng nếu từ có nhiều nghĩa thì phải xét ngữ cảnh.

03

Cũng cần luyện đọc lịch làm việc và thông báo. Đánh dấu ngày, giờ bắt đầu, địa điểm và đồ cần chuẩn bị. Hỏi người phụ trách phần chưa hiểu. Không tự ý chia sẻ lịch làm việc của người khác hoặc tài liệu có thông tin cá nhân.

04

Ôn tập không chỉ là đọc lại từ. Hãy che nghĩa rồi tự nói, đặt câu và giải thích cho bạn học. Đánh dấu cách diễn đạt hay sai để hỏi trong buổi sau. Kết quả của bài học là một sổ từ vựng cá nhân có thể dùng trong cuộc sống.

06. TOPIK II 3급 목표 학습

한국어 | 계획 40시간 | 교안

설명·시연 14시간 / 연습·실습 22시간 / 평가·피드백 4시간

학습 목표

- TOPIK II 듣기·읽기·쓰기 유형을 익힌다.

- 진단 결과에 따라 보충 학습 계획을 세운다.

준비물: 공식 시험 안내·공개 학습자료, 답안지, 오답 기록장

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

진단평가 후 듣기·읽기·쓰기 영역별 학습을 진행합니다. 공개 자료로 시간 제한 연습을 하고 오답 원인을 기록합니다. 쓰기는 강사 피드백 후 다시 작성합니다.

확인 문제와 해설

병원 회화를 잘하면 TOPIK II 쓰기 준비를 생략해도 될까요?

해설: 아니요. TOPIK II의 듣기·읽기·쓰기를 별도로 준비하고 병원 회화는 추가로 연습합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

06. TOPIK II 3급 목표 학습

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 강의 원고

우리 과정의 한국어 목표는 한국어능력시험, 토픽 투, 삼 급 이상입니다. 토픽 원은 일 급과 이 급 시험이므로 삼 급 목표와 구분해야 합니다. 응시 방식과 일정은 접수 전에 공식 안내에서 확인합니다.

02 / 강의 원고

토픽 투는 듣기, 읽기, 쓰기를 준비합니다. 병원 회화 수업은 현장 의사소통에 필요하지만 시험의 쓰기 준비를 대신하지 않습니다. 첫 진단평가에서 어휘, 문법, 문장 이해, 쓰기 능력을 확인하고 개인별 부족한 영역을 정리합니다.

03 / 강의 원고

듣기에서는 상황과 핵심 내용을 먼저 파악합니다. 읽기에서는 문장의 연결 관계와 중심 생각을 확인합니다. 쓰기는 문제의 요구를 빠뜨리지 않고 알맞은 문장으로 표현하는 연습을 합니다. 강사의 설명을 들은 뒤 본인이 다시 써 보는 과정이 필요합니다.

04 / 강의 원고

모의 연습은 점수만 확인하지 않습니다. 틀린 이유를 어휘 부족, 시간 부족, 질문 오해 등으로 분류하고 다음 주 계획에 반영합니다. 백육십 시간 수강이 삼 급 취득을 보장하지는 않습니다. 필요한 보충교육을 받고, 과정 수료와 실제 시험 성적은 별도로 기록합니다.

학습 메모

_____

_____

06. TOPIK II 3급 목표 학습

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Mục tiêu tiếng Hàn của khóa học là TOPIK II cấp 3 trở lên. TOPIK I là kỳ thi cấp 1 và 2 nên phải phân biệt với mục tiêu cấp 3. Trước khi đăng ký, hãy kiểm tra hình thức và lịch thi trong thông báo chính thức.

02

TOPIK II cần chuẩn bị nghe, đọc và viết. Hội thoại bệnh viện cần cho giao tiếp thực tế, nhưng không thay thế việc luyện viết của kỳ thi. Đánh giá đầu vào kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, hiểu câu và viết để xác định phần mỗi người còn thiếu.

03

Khi nghe, trước hết nắm tình huống và nội dung chính. Khi đọc, xác định quan hệ giữa các câu và ý chính. Khi viết, luyện đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bằng câu phù hợp. Sau khi nghe giảng viên giải thích, cần tự viết lại.

04

Thi thử không chỉ để xem điểm. Hãy phân loại nguyên nhân sai như thiếu từ vựng, thiếu thời gian hoặc hiểu nhầm câu hỏi, rồi đưa vào kế hoạch tuần sau. Học 160 giờ không bảo đảm đạt cấp 3. Cần học bổ sung khi cần và ghi riêng việc hoàn thành khóa học với kết quả thi thực tế.

G01. 돌봄 기본원칙·직업윤리·보고

일반교육 | 계획 4시간 | 교안

설명·시연 1시간 / 연습·실습 2시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 관찰·기록·보고 순서와 응급 호출 우선 원칙을 적용한다.

- 동의를 구하고 경청·감정 인정·도움 연결을 역할극으로 수행한다.

- 추측한 진단 대신 사실과 환자의 말로 정서 변화를 기록한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 시작 전 확인 / 돌봄 중 의사소통 / 관찰과 보고 요령 / 마무리·실습 평가 / 말벗의 시작·경청 / 위로가 되는 말·피할 말 / 불안·외로움·상황별 대화 / 작은 활동·선호·경계 / 정서 관찰·기록·보고 / 즉시 연결할 신호·실습 / 일상생활지원·할 수 있는 만큼 스스로 / 생활지원의 하루 순서 / 개인활동지원·선택과 참여 / 활동 관찰·기록·보고와 경계

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 동의받기와 보고 역할극입니다. 환자가 도움을 거절하는 사례를 사용합니다. 이유를 듣고 필요한 사항을 담당자에게 알렸는지, 개인정보를 보호했는지 관찰표로 평가합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G01 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 말·표정·도움에 대한 반응입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

반복 거절이나 통증 호소 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 9시 세면을 거절하며 춥다고 말함. 담요를 덮고 시간을 조정하자 동의함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 말에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G01. 돌봄 기본원칙·직업윤리·보고

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 말·표정·도움에 대한 반응를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 반복 거절이나 통증 호소는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 시작 전 확인

시작 전 확인입니다. 이름을 확인하고 오늘 할 돌봄을 짧게 설명한 뒤 동의를 구합니다. 인계장에서 금식, 이동 도움 수준, 격리, 알레르기, 부착된 관과 비상 연락 방법을 확인합니다. 손 위생 후 필요한 물품을 손에 닿는 곳에 놓고 가림막을 칩니다. 환자가 직접 할 수 있는 부분은 대신하지 말고 기다립니다.

03 / 돌봄 중 의사소통

돌봄 중 의사소통입니다. 한 번에 한 가지를 말하고 대답할 시간을 줍니다. 통증이 있는지 먼저 묻고, 몸을 만지거나 자세를 바꾸기 전에 예고합니다. 거절하면 이유가 통증인지 추위인지 수치심인지 확인합니다. 강제로 진행하지 말고 가능한 시간이나 방법을 간호사와 조정합니다.

04 / 관찰과 보고 요령

관찰과 보고 요령입니다. 보고는 환자 이름, 발생 시각, 평소와 달라진 모습, 이미 한 도움의 순서로 말합니다. 예를 들어 오후 두 시 목욕 준비 중 숨이 차다고 하여 중단하고 앉혀 쉬게 했습니다, 지금 확인해 주세요라고 전달합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

05 / 마무리·실습 평가

마무리·실습 평가입니다. 침상을 안전한 높이로 내리고 호출벨과 필요한 물품을 손에 닿게 합니다. 수행한 도움, 환자의 반응, 보고한 사람과 후속 지시를 기록합니다. 실습은 동의받기, 인계 확인, 거절 시 대응, 긴급 보고를 역할극으로 평가합니다. 투약·관 삽입·처치 판단은 간병인이 독자적으로 수행하지 않습니다.

06 / 말벗의 시작·경청

말벗의 시작·경청입니다. 먼저 지금 잠깐 이야기 나눠도 괜찮으세요라고 묻고 눈높이를 맞춥니다. 보청기와 안경, 조용한 환경을 확인합니다. 오늘 가장 마음 쓰이는 일이 무엇인지 묻고 말을 끊지 않고 기다립니다. 대화를 원하지 않으면 억지로 묻지 않고 조용히 곁에 있어도 될지 확인합니다. 아기 대하듯 말하거나 반말하지 않습니다.

07 / 위로가 되는 말·피할 말

위로가 되는 말·피할 말입니다. 많이 걱정되고 외로우시겠어요, 말씀해 주셔서 감사합니다, 지금 제가 어떻게 도와드리면 좋을까요처럼 감정을 인정합니다. 다 괜찮아질 거예요, 다른 분은 더 힘들어요, 울지 마세요처럼 회복을 보장하거나 감정을 비교·억누르는 말은 피합니다. 진단과 예후 질문은 아는 척 답하지 말고 담당 의료진에게 연결합니다.

08 / 불안·외로움·상황별 대화

불안·외로움·상황별 대화입니다. 숨이 차 무섭다는 환자에게 곁에 있겠습니다, 간호사에게 바로 도움을 요청하겠습니다라고 말하며 신체 상태를 먼저 확인합니다. 숨참을 불안 탓으로 단정하지 않습니다. 가족이 보고 싶으면 동의를 받아 연락 방법을 담당자와 상의합니다. 치매 환자는 짧은 말로 안심시키고, 암·호스피스 환자는 감정을 바꾸려 하지 말고 들어 줍니다.

09 / 작은 활동·선호·경계

작은 활동·선호·경계입니다. 환자가 원하면 익숙한 음악, 사진 이야기, 짧은 독서나 허용된 산책을 함께합니다. 피곤해지면 멈추고 다음 시간을 묻습니다. 손잡기 같은 신체 접촉도 먼저 동의를 구합니다. 종교·문화·가족 이야기를 강요하지 않고 금전 거래나 개인적인 약속을 하지 않습니다. 개인 휴대전화로 사진을 찍거나 사적인 내용을 공유하지 않습니다.

10 / 정서 관찰·기록·보고

정서 관찰·기록·보고입니다. 표정, 말수, 눈물, 잠과 식사, 반복되는 불안 표현을 평소와 비교합니다. 우울증이라고 진단하지 말고 환자의 말과 행동을 그대로 기록합니다. 예를 들어 저녁 일곱 시 가족이 보고 싶다고 말하며 눈물을 보임, 동의를 얻어 십 분간 경청, 가족 연락을 원하여 간호사에게 전달함이라고 적습니다. 지속되거나 돌봄을 방해하는 불안은 담당팀에 보고합니다.

11 / 즉시 연결할 신호·실습

즉시 연결할 신호·실습입니다. 죽고 싶다거나 자신을 해치겠다는 말은 가볍게 넘기거나 비밀로 하겠다고 약속하지 않습니다. 차분히 듣고 즉시 간호사와 병원 비상 지원체계에 알리며 안전이 확보될 때까지 혼자 두지 않습니다. 간병인이 상담과 치료를 혼자 맡지 않습니다. 역할극은 대화 동의, 경청, 감정 인정, 필요한 도움 연결, 사실 기록을 평가합니다.

12 / 일상생활지원·할 수 있는 만큼 스스로

일상생활지원·할 수 있는 만큼 스스로입니다. 식사, 배설, 세면·목욕, 옷 입기, 이동·체위, 휴식과 수면은 일상생활지원의 기본입니다. 먼저 무엇을 스스로 할 수 있는지 묻고 개별 계획을 확인합니다. 지켜보기, 말로 안내하기, 필요한 부분만 돕기 순서로 지원합니다. 시간이 걸린다는 이유로 전부 대신하지 않습니다. 안경·보청기·보조 식기를 준비하고 사생활을 지킵니다.

13 / 생활지원의 하루 순서

생활지원의 하루 순서입니다. 아침에는 의사와 컨디션을 확인하고 세면·옷 갈아입기·배설·식사를 계획합니다. 낮에는 필요한 이동과 휴식을 나누고 저녁에는 구강 위생, 편한 옷과 잠자리·호출벨을 확인합니다. 환자 선호와 병원 일정을 조정하며 획일적으로 강요하지 않습니다. 못 하던 일을 하거나 하던 일을 못 하게 된 변화도 기록합니다.

14 / 개인활동지원·선택과 참여

개인활동지원·선택과 참여입니다. 환자가 원하는 독서, 음악, 사진 이야기, 취미, 가족 통화와 허용된 산책·사회 활동을 함께 계획합니다. 외래 진료나 검사 동행은 병원 승인, 이동 방법, 필요한 인원과 관·산소 계획을 먼저 확인합니다. 방문 목적과 다음 순서를 쉽게 설명하고 피곤하거나 아프면 활동을 멈춰 담당자에게 알립니다. 외출을 임의로 허락하지 않습니다.

15 / 활동 관찰·기록·보고와 경계

활동 관찰·기록·보고와 경계입니다. 활동 전후 표정, 참여 의사, 피로·통증·숨참·균형을 관찰합니다. 무엇을 얼마나 했고 어느 부분을 혼자 했는지, 어떤 도움과 중단 이유가 있었는지 기록합니다. 예를 들어 오전 열 시 허용된 복도 산책 중 피곤하다고 말해 의자에서 쉬고 간호사에게 알림이라고 적습니다. 금전·비밀번호·서명 대행 등은 개인적으로 맡지 말고 공식 담당자에게 연결합니다.

학습 메모

_____

_____

G01. 돌봄 기본원칙·직업윤리·보고

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Xác nhận tên, giải thích ngắn việc sẽ làm và xin đồng ý. Kiểm tra nhịn ăn, mức hỗ trợ di chuyển, cách ly, dị ứng, ống và cách gọi khẩn cấp trong bàn giao. Vệ sinh tay, chuẩn bị đồ trong tầm với, che kín. Chờ người bệnh tự làm phần có thể.

03

Nói từng việc, chờ trả lời. Hỏi đau và báo trước khi chạm hay đổi tư thế. Khi bị từ chối, tìm hiểu đau, lạnh hay ngại. Không ép; trao đổi với điều dưỡng để đổi thời điểm hoặc cách chăm sóc.

04

Báo tên, thời điểm, thay đổi so với thường ngày và hỗ trợ đã làm. Ví dụ: lúc hai giờ khi chuẩn bị tắm người bệnh khó thở, đã dừng và cho nghỉ ngồi, xin kiểm tra ngay. Khó thở nặng hoặc thay đổi ý thức: gọi khẩn cấp trước khi ghi chép.

05

Hạ giường an toàn, đặt chuông và vật dụng trong tầm với. Ghi hỗ trợ, phản ứng, người nhận báo cáo và chỉ dẫn tiếp theo. Đánh giá qua xin đồng ý, bàn giao, xử lý từ chối và báo khẩn. Người chăm sóc không tự quyết định thuốc, đặt ống hay thủ thuật.

06

Trước tiên hỏi có thể trò chuyện một chút không, ngang tầm mắt. Kiểm tra kính, máy trợ thính, môi trường yên. Hỏi điều bận tâm nhất hôm nay, nghe không ngắt lời. Không muốn nói thì không ép; hỏi có thể ngồi yên bên cạnh không. Không nói như với trẻ nhỏ hay thiếu tôn trọng.

07

Công nhận cảm xúc: chắc bác lo và cô đơn nhiều, cảm ơn đã chia sẻ, lúc này tôi giúp gì được? Tránh hứa sẽ khỏi hết, so người khác khổ hơn, bảo đừng khóc. Không giả vờ biết chẩn đoán, tiên lượng; nối với nhân viên y tế.

08

Người sợ vì khó thở: nói tôi ở đây, sẽ gọi điều dưỡng ngay, đồng thời kiểm tra thể chất. Không quy khó thở cho lo âu. Nhớ gia đình: xin đồng ý rồi bàn cách liên lạc với người phụ trách. Sa sút trí tuệ dùng câu ngắn; ung thư, hospice thì lắng nghe, không ép đổi cảm xúc.

09

Nếu muốn, cùng nghe nhạc quen, nói chuyện ảnh, đọc ngắn, đi dạo được phép. Mệt thì dừng, hỏi lúc khác. Xin phép cả khi nắm tay. Không ép tôn giáo, văn hóa, gia đình; không giao dịch tiền hay hứa riêng. Không chụp bằng điện thoại cá nhân hoặc chia sẻ chuyện riêng.

10

So với thường ngày: nét mặt, nói ít, khóc, ngủ, ăn, lời lo lặp. Không chẩn đoán trầm cảm; ghi lời, hành vi. Ví dụ 19 giờ nói nhớ gia đình và khóc, đồng ý nghe 10 phút, muốn liên lạc nên báo điều dưỡng. Lo kéo dài, cản chăm sóc cần báo nhóm.

11

Lời muốn chết hay tự hại không được xem nhẹ hoặc hứa giữ bí mật. Bình tĩnh nghe, báo điều dưỡng và hệ thống khẩn, không để một mình tới khi an toàn. Không tự đảm nhận tư vấn điều trị. Luyện xin đồng ý, nghe, công nhận cảm xúc, kết nối hỗ trợ và ghi sự thật.

12

Ăn, bài tiết, rửa tắm, mặc, di chuyển đổi tư thế, nghỉ ngủ là hỗ trợ sinh hoạt. Hỏi phần tự làm và kiểm tra kế hoạch. Theo mức quan sát, hướng dẫn bằng lời, giúp phần cần. Không làm thay hết vì chậm. Chuẩn bị kính, máy trợ thính, dụng cụ ăn; giữ riêng tư.

13

Buổi sáng hỏi ý muốn, sức khỏe, sắp rửa mặc vệ sinh ăn. Ban ngày chia di chuyển và nghỉ; tối kiểm tra vệ sinh miệng, áo, giường, chuông. Điều chỉnh theo sở thích, lịch viện, không ép cứng nhắc. Ghi cả tiến bộ và giảm khả năng tự làm.

14

Cùng lên kế hoạch đọc, nhạc, ảnh, sở thích, gọi gia đình, đi dạo và giao lưu được phép. Đi khám, xét nghiệm cần xác nhận cho phép, cách chuyển, người hỗ trợ, ống oxy. Giải thích mục đích và bước tiếp, mệt đau thì dừng và báo. Không tự cho ra ngoài.

15

Quan sát mặt, muốn tham gia, mệt đau khó thở, thăng bằng trước sau. Ghi làm gì bao lâu, phần tự làm, hỗ trợ và lý do dừng. Ví dụ 10 giờ đi hành lang được phép, nói mệt nên nghỉ ghế và báo điều dưỡng. Không tự giữ tiền, mật khẩu hay ký thay; nối người phụ trách chính thức.

G02. 기저귀 사용 환자·배설·피부 돌봄

일반교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 배설 요구 확인과 화장실 이용 지원 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 준비와 자세 / 교환 순서 / 피부 보호와 주의 / 마무리·기록·실습 / 소변·시간·양·색 기록 / 기저귀 무게·추정값 구분 / 대변·횟수·형태·무게 / 교대 합계·누락·보고 / 눈금컵으로 양 읽기

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 사례 실습은 환자의 거절과 피부 불편 호소를 함께 다룹니다. 존중하는 설명, 청결·오염 물품 구분, 안전한 도움 요청, 이상 관찰 보고의 네 항목을 평가합니다. 실습용 눈금컵과 저울로 제공량·잔량·용기 무게를 확인하고 실측·추정·측정 불가를 구분해 기록하는 과제를 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G02 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 기저귀 오염·피부색·배설 변화입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

피부 벗겨짐·출혈·반복 설사 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 10시 교환 중 엉치 피부의 붉음과 따가움 호소를 확인함. 문지르지 않고 담당자에게 알림.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 기저귀 오염에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G02 섭취·배설 수치 기록 실습

모두 가상 계산 예시이며 정상량이나 환자별 목표가 아닙니다. 측정 방법·주기·보고 기준은 해당 병원 지시를 따릅니다. 식품용과 배설물용 도구를 구분합니다.

시간/구간	항목	측정 내역	기록할 수치	상태·측정 방법
08:00	물	제공 200 mL / 남음 80 mL	120 mL 섭취	눈금 실측·흘림 없음
08:10	죽	제공 200 g / 남음 50 g	150 g 섭취	용기 무게 제외·흘림 없음
08:00–10:00	소변	전용 눈금 용기	250 mL 배출	연한 노란색·통증 없음
10:20	대변	총 180 g / 용기 40 g	140 g / 1회	갈색·형성변·혈액 없음
12:00	기저귀 소변	젖음 280 g / 마름 30 g	약 250 mL 추정	소변만·누출 없음·병원 환산법
14:00	혼합 기저귀	소변·대변이 섞임	소변량 측정 불가	0 mL로 입력하지 않음

작성 연습

환자 / 날짜 / 시간·구간 / 음식·배설 종류 / 제공량 / 남은 양 / 흘린 양 / 실제량 / 단위 / 실측·추정·불가 / 색·형태·증상 / 작성자 / 보고 시각·대상 / 받은 지시

_____

_____

_____

G02. 기저귀 사용 환자·배설·피부 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 기저귀 오염·피부색·배설 변화를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 피부 벗겨짐·출혈·반복 설사는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 준비와 자세

준비와 자세입니다. 배설 의사와 통증을 묻고 화장실이나 이동변기 이용이 가능한지 계획을 확인합니다. 새 기저귀, 세정 물품, 수건, 폐기 봉투를 준비하고 손 위생과 장갑 착용 후 몸을 가립니다. 체위변경에 두 사람이 필요하면 먼저 도움을 부릅니다. 마비된 팔이나 관을 잡아당기지 않습니다.

03 / 교환 순서

교환 순서입니다. 오염된 기저귀를 안쪽으로 말아 분리합니다. 피부는 병원 지침의 세정제로 부드럽게 닦고 회음부는 앞에서 뒤쪽으로, 깨끗한 부위에서 오염된 부위 방향으로 정리합니다. 닦은 면을 반복 사용하지 않습니다. 피부 주름까지 가볍게 눌러 말리고 깨끗한 기저귀를 주름 없이 대되 너무 조이지 않습니다.

04 / 피부 보호와 주의

피부 보호와 주의입니다. 젖거나 대변에 오염되면 오래 방치하지 않고 교환합니다. 피부보호제는 지정된 제품과 사용 지시에 따릅니다. 붉어진 부위를 세게 문지르거나 마사지하지 않고, 기저귀를 여러 겹 겹치지 않습니다. 발적, 벗겨짐, 진물, 통증, 혈변이나 검은 변은 시각과 함께 간호사에게 알립니다.

05 / 마무리·기록·실습

마무리·기록·실습입니다. 장갑을 벗고 손 위생을 한 뒤 편안한 자세와 호출벨을 확인합니다. 배설 시각, 대략적인 양과 성상, 피부 상태를 기록합니다. 설사가 반복되거나 소변이 평소보다 현저히 줄면 보고합니다. 모형에서 오염물 분리, 앞에서 뒤로 닦기, 피부 건조, 안전한 체위변경을 순서대로 시연합니다.

06 / 소변·시간·양·색 기록

소변·시간·양·색 기록입니다. 소변은 병원에서 지정한 눈금 용기와 방법으로 측정하고 밀리리터로 적습니다. 날짜·시각, 측정한 구간, 양, 색·탁도·혈액 여부와 통증을 기록합니다. 예를 들어 오전 여덟 시부터 열 시까지 이백오십 밀리리터, 연한 노란색, 통증 없음이라고 적습니다. 같은 소변을 주머니 눈금과 비운 양으로 두 번 합산하지 않습니다. 측정하려고 관 연결을 분리하지 않습니다.

07 / 기저귀 무게·추정값 구분

기저귀 무게·추정값 구분입니다. 병원이 기저귀 계량법을 정한 경우에만 동일 제품의 마른 기저귀 무게를 뺍니다. 젖은 무게 이백팔십 그램에서 마른 무게 삼십 그램을 빼면 증가분은 이백오십 그램입니다. 소변만 포함되고 누출이 없을 때 병원 기준에 따라 약 이백오십 밀리리터로 추정했다고 표시합니다. 대변·세정액이 섞이거나 누출되면 정확한 소변량으로 환산하지 말고 혼합 또는 측정 불가와 이유를 적습니다.

08 / 대변·횟수·형태·무게

대변·횟수·형태·무게입니다. 대변은 배변 시각, 횟수, 색, 형태, 혈액·점액과 통증을 기록합니다. 병원이 사용하는 형태 분류를 함께 적고 색만으로 진단하지 않습니다. 무게 측정 지시와 전용 저울·용기가 있으면 오염물을 안전하게 처리하며 용기 무게를 뺀 그램으로 기록합니다. 예를 들어 용기 포함 백팔십 그램에서 용기 사십 그램을 빼면 대변은 백사십 그램입니다. 대변 무게를 그대로 소변량이나 수분 배출량으로 더하지 않습니다.

09 / 교대 합계·누락·보고

교대 합계·누락·보고입니다. 행마다 환자, 날짜·시각과 작성자를 확인하고 섭취·배출 직후 기록합니다. 교대나 병원이 정한 하루 구간에 밀리리터 항목끼리 합산합니다. 소변, 측정한 구토·액상 배출은 구분하고 음식·대변의 그램 기록과 섞지 않습니다. 측정하지 못함은 영이 아니므로 이유와 누락을 전달합니다. 수분 균형의 의미와 제한량 조정은 의료진이 판단합니다. 갑작스러운 소변 감소, 혈액, 검은 변, 반복 구토·설사는 합계 시간을 기다리지 말고 보고합니다.

10 / 눈금컵으로 양 읽기

눈금컵으로 양 읽기입니다. 물과 음료는 눈금이 있는 식품용 컵에, 소변은 별도의 전용 눈금 용기에 담아 측정합니다. 평평한 곳에 두고 액면과 눈높이를 맞춰 밀리리터 눈금을 읽습니다. 용기 용량을 확인하고 넘침·흘림·남은 양을 구분합니다. 읽을 수 없는 눈금은 추측하지 않습니다. 정확한 소변 계량을 위해 관 연결을 분리하지 말고 병원이 정한 방법을 따릅니다.

학습 메모

_____

_____

G02. 기저귀 사용 환자·배설·피부 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Hỏi nhu cầu bài tiết và đau; kiểm tra khả năng dùng nhà vệ sinh hay ghế bô. Chuẩn bị tã sạch, đồ rửa, khăn, túi rác; vệ sinh tay, đeo găng và che kín. Nếu cần hai người để đổi tư thế, gọi hỗ trợ trước. Không kéo tay liệt hoặc ống.

03

Cuộn mặt bẩn của tã vào trong. Lau nhẹ theo quy trình bệnh viện; vùng kín lau từ trước ra sau, từ sạch đến bẩn, không dùng lại mặt khăn bẩn. Thấm khô cả nếp da. Đặt tã sạch phẳng, không siết chặt.

04

Thay khi ướt hoặc dính phân, không để lâu. Dùng sản phẩm bảo vệ da được chỉ định. Không chà hay xoa bóp vùng đỏ, không chồng nhiều tã. Báo đỏ, trầy, rỉ dịch, đau, phân máu hoặc đen cùng thời điểm.

05

Bỏ găng, vệ sinh tay, kiểm tra tư thế và chuông. Ghi thời gian, lượng tương đối, tính chất bài tiết và da. Báo tiêu chảy lặp lại hoặc tiểu giảm rõ. Thực hành tách đồ bẩn, lau trước ra sau, làm khô và đổi tư thế an toàn trên mô hình.

06

Đo nước tiểu bằng dụng cụ chia vạch, cách viện chỉ định, ghi mL. Ghi ngày giờ, khoảng đo, lượng, màu, độ đục, máu, đau. Ví dụ 08–10 giờ: 250 mL, vàng nhạt, không đau. Không cộng hai lần cùng lượng từ vạch túi và lượng đã xả. Không tháo nối chỉ để đo.

07

Chỉ cân tã theo quy trình viện, trừ tã khô cùng loại. 280 g ướt trừ 30 g khô = tăng 250 g. Nếu chỉ có nước tiểu, không rò, ghi ước tính khoảng 250 mL theo viện. Có phân, nước rửa, rò thì không đổi thành nước tiểu chính xác; ghi lẫn hoặc không đo được và lý do.

08

Ghi giờ, số lần, màu, dạng phân, máu nhầy và đau. Dùng phân loại của viện, không chẩn đoán từ màu. Khi có chỉ định cân, cân và hộp riêng, xử lý an toàn rồi trừ bì, ghi g. 180 g cả hộp trừ 40 g hộp = 140 g phân. Không cộng gam phân thành nước tiểu hay dịch ra.

09

Xác nhận người, ngày giờ, người ghi; ghi ngay sau ăn uống, bài tiết. Cộng các mục mL theo ca hay khoảng ngày viện quy định. Tách tiểu, nôn đo được, dịch lỏng; không trộn với g thức ăn, phân. Không đo được không phải số 0; bàn giao lý do, thiếu. Y tế đánh giá cân bằng và điều chỉnh. Tiểu giảm đột ngột, máu, phân đen, nôn tiêu chảy lặp phải báo ngay.

10

Đo nước uống bằng cốc thực phẩm chia vạch, nước tiểu bằng dụng cụ riêng. Đặt phẳng, mắt ngang mặt dịch, đọc mL. Kiểm tra dung tích, tách phần tràn, đổ, còn. Không đoán vạch không đọc được. Không tháo nối ống để đo; theo cách viện quy định.

G03. 식사돌봄·수분·구강 위생

일반교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 식이·금식·삼킴 관련 개별 지시 확인 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 먹기 전 확인 / 한 숟가락씩 돕기 / 기침·질식 대응 / 식후 정리 / 음식·제공량과 남은 양 / 물·음료 실제 섭취량 / 교대 합계·누락·보고 / 눈금컵으로 양 읽기

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 섭취와 거절 내용을 사실대로 기록하고 구강 위생은 개별 계획에 따라 지원합니다. 모의 식사 실습에서는 식이 확인, 동의, 관찰, 중단과 보고를 평가하며 경관영양은 별도의 전문교육으로 다룹니다. 실습용 눈금컵과 저울로 제공량·잔량·용기 무게를 확인하고 실측·추정·측정 불가를 구분해 기록하는 과제를 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G03 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 깨어 있는 정도·삼킴·기침·먹은 양입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

기침·젖은 목소리·삼키기 어려움 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

낮 12시 식사 세 숟가락 후 두 차례 기침하고 목소리가 젖은 듯 들림. 식사를 중단하고 간호사를 부름.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 깨어 있는 정도에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G03 섭취·배설 수치 기록 실습

모두 가상 계산 예시이며 정상량이나 환자별 목표가 아닙니다. 측정 방법·주기·보고 기준은 해당 병원 지시를 따릅니다. 식품용과 배설물용 도구를 구분합니다.

시간/구간	항목	측정 내역	기록할 수치	상태·측정 방법
08:00	물	제공 200 mL / 남음 80 mL	120 mL 섭취	눈금 실측·흘림 없음
08:10	죽	제공 200 g / 남음 50 g	150 g 섭취	용기 무게 제외·흘림 없음
08:00–10:00	소변	전용 눈금 용기	250 mL 배출	연한 노란색·통증 없음
10:20	대변	총 180 g / 용기 40 g	140 g / 1회	갈색·형성변·혈액 없음
12:00	기저귀 소변	젖음 280 g / 마름 30 g	약 250 mL 추정	소변만·누출 없음·병원 환산법
14:00	혼합 기저귀	소변·대변이 섞임	소변량 측정 불가	0 mL로 입력하지 않음

작성 연습

환자 / 날짜 / 시간·구간 / 음식·배설 종류 / 제공량 / 남은 양 / 흘린 양 / 실제량 / 단위 / 실측·추정·불가 / 색·형태·증상 / 작성자 / 보고 시각·대상 / 받은 지시

_____

_____

_____

G03. 식사돌봄·수분·구강 위생

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 깨어 있는 정도·삼킴·기침·먹은 양를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 기침·젖은 목소리·삼키기 어려움는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 먹기 전 확인

먹기 전 확인입니다. 금식, 식이 종류, 음식 질감, 수분 농도와 제한량, 삼킴 평가 결과를 확인합니다. 깨어 있고 호흡이 안정된 때 식사를 돕습니다. 몸통과 머리가 한쪽으로 기울지 않도록 지지하며 가능한 똑바로 앉힙니다. 눕힌 채 먹이거나 임의로 턱을 당기는 자세를 적용하지 않습니다.

03 / 한 숟가락씩 돕기

한 숟가락씩 돕기입니다. 환자 눈높이에서 설명하고 적은 양을 천천히 제공합니다. 한 입을 삼킨 것을 확인한 뒤 다음 숟가락을 줍니다. 입에 음식이 있을 때 대답을 재촉하지 않습니다. 빨대, 점도 조절제, 음식 혼합은 삼킴 계획에 정해진 경우에만 사용합니다. 스스로 잡을 수 있는 식기와 손 사용을 지원합니다.

04 / 기침·질식 대응

기침·질식 대응입니다. 기침, 젖은 목소리, 음식이 입에 고임, 숨참이 나타나면 즉시 식사를 멈추고 간호사를 부릅니다. 물로 밀어 넘기지 않습니다. 말을 못 하거나 숨을 못 쉬는 질식은 비상 호출 후 교육받은 기도폐쇄 응급처치를 병원 절차에 따라 시행합니다. 보이지 않는 음식물을 손가락으로 찾지 않습니다.

05 / 식후 정리

식후 정리입니다. 입안에 남은 음식을 확인하고 교육받은 방법으로 구강 위생을 돕습니다. 식후에는 개별 계획에 정한 시간 동안 상체를 세워 둡니다. 섭취량, 수분량, 기침 발생과 거절 이유를 기록합니다. 실습에서는 식이 확인부터 한 입씩 기다리기와 중단 판단까지 연습합니다.

06 / 음식·제공량과 남은 양

음식·제공량과 남은 양입니다. 음식은 이름과 형태, 제공 시각, 용기를 뺀 제공 무게와 남은 무게를 그램으로 적습니다. 예를 들어 죽 이백 그램을 주고 오십 그램이 남았다면 실제 섭취는 백오십 그램입니다. 흘린 양이나 버린 양이 있으면 따로 구분해야 하며 제공량을 먹은 양으로 적지 않습니다. 간식도 포함하고, 달지 못한 음식은 반 공기 같은 병원 기준의 추정량임을 표시합니다. 음식 그램을 모두 물 밀리리터로 바꾸지 않습니다.

07 / 물·음료 실제 섭취량

물·음료 실제 섭취량입니다. 컵마다 용량이 다르므로 눈금으로 확인합니다. 물 이백 밀리리터를 주고 팔십 밀리리터가 남으면 흘린 양이 없을 때 실제 섭취는 백이십 밀리리터입니다. 물·우유·차·영양 음료 등을 종류별로 기록하고 국물 등은 병원 수분 계산 기준에 맞춥니다. 섭취 시각과 남긴 이유도 적습니다. 수분 제한 환자에게 기록 목표를 채우려고 억지로 마시게 하지 않습니다.

08 / 교대 합계·누락·보고

교대 합계·누락·보고입니다. 행마다 환자, 날짜·시각과 작성자를 확인하고 섭취·배출 직후 기록합니다. 교대나 병원이 정한 하루 구간에 밀리리터 항목끼리 합산합니다. 소변, 측정한 구토·액상 배출은 구분하고 음식·대변의 그램 기록과 섞지 않습니다. 측정하지 못함은 영이 아니므로 이유와 누락을 전달합니다. 수분 균형의 의미와 제한량 조정은 의료진이 판단합니다. 갑작스러운 소변 감소, 혈액, 검은 변, 반복 구토·설사는 합계 시간을 기다리지 말고 보고합니다.

09 / 눈금컵으로 양 읽기

눈금컵으로 양 읽기입니다. 물과 음료는 눈금이 있는 식품용 컵에, 소변은 별도의 전용 눈금 용기에 담아 측정합니다. 평평한 곳에 두고 액면과 눈높이를 맞춰 밀리리터 눈금을 읽습니다. 용기 용량을 확인하고 넘침·흘림·남은 양을 구분합니다. 읽을 수 없는 눈금은 추측하지 않습니다. 정확한 소변 계량을 위해 관 연결을 분리하지 말고 병원이 정한 방법을 따릅니다.

학습 메모

_____

_____

G03. 식사돌봄·수분·구강 위생

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Kiểm tra nhịn ăn, chế độ ăn, dạng thức ăn, độ đặc và giới hạn nước, đánh giá nuốt. Chỉ hỗ trợ khi tỉnh và thở ổn. Đỡ thân, đầu không nghiêng, ngồi thẳng nếu được. Không cho ăn nằm hay tự áp dụng tư thế cúi cằm.

03

Giải thích ở ngang tầm mắt, cho lượng nhỏ chậm. Xác nhận đã nuốt rồi mới cho thìa tiếp. Không thúc trả lời khi còn thức ăn. Ống hút, chất làm đặc hay trộn thức ăn chỉ dùng theo kế hoạch nuốt. Hỗ trợ dụng cụ để tự ăn.

04

Nếu ho, giọng ướt, thức ăn đọng hay khó thở, dừng ăn và gọi điều dưỡng. Không ép uống nước để đẩy thức ăn. Không nói hoặc thở được do nghẹn: gọi khẩn và sơ cứu tắc đường thở đã được đào tạo theo quy trình. Không móc ngón tay tìm vật không thấy.

05

Kiểm tra thức ăn còn trong miệng, vệ sinh miệng theo hướng dẫn. Giữ thân trên cao sau ăn trong thời gian quy định riêng. Ghi lượng ăn, nước, ho và lý do từ chối. Thực hành từ kiểm tra suất ăn đến chờ từng lần nuốt và quyết định dừng.

06

Ghi tên, dạng, giờ, khối lượng cho và còn sau trừ bì bằng g. Cho cháo 200 g, còn 50 g: ăn 150 g. Tách phần đổ hay bỏ; không ghi lượng cho là lượng ăn. Kể cả bữa phụ. Không cân được thì ghi ước tính theo viện, như nửa bát. Không đổi mọi gam thức ăn thành mL nước.

07

Dung tích cốc khác nhau, kiểm tra vạch. Cho nước 200 mL còn 80 mL, không đổ: uống 120 mL. Ghi riêng nước, sữa, trà, dinh dưỡng; nước canh theo quy tắc tính dịch của viện. Ghi giờ, lý do còn. Không ép người hạn chế dịch uống để đạt con số.

08

Xác nhận người, ngày giờ, người ghi; ghi ngay sau ăn uống, bài tiết. Cộng các mục mL theo ca hay khoảng ngày viện quy định. Tách tiểu, nôn đo được, dịch lỏng; không trộn với g thức ăn, phân. Không đo được không phải số 0; bàn giao lý do, thiếu. Y tế đánh giá cân bằng và điều chỉnh. Tiểu giảm đột ngột, máu, phân đen, nôn tiêu chảy lặp phải báo ngay.

09

Đo nước uống bằng cốc thực phẩm chia vạch, nước tiểu bằng dụng cụ riêng. Đặt phẳng, mắt ngang mặt dịch, đọc mL. Kiểm tra dung tích, tách phần tràn, đổ, còn. Không đoán vạch không đọc được. Không tháo nối ống để đo; theo cách viện quy định.

G04. 샤워·목욕·세면·청결 돌봄

일반교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 목욕 가능 여부·개인 선호·동의 확인 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 목욕 전 준비

- 씻기는 순서

- 중단해야 할 상황

- 목욕 후 관리

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 모형 실습으로 가림막, 설명, 안전 확인, 청결 지원과 정리를 연습합니다. 실제 환자의 이동 방법은 개별 계획과 감독에 따릅니다. 평가에서는 환자 동의와 낙상·화상 위험 확인을 반드시 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G04 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 안색·어지럼·숨참·피부 변화입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

어지럼·흉통·숨참 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 11시 샤워 의자에 앉은 뒤 어지럽다고 말함. 샤워를 중단하고 안전하게 지지하며 도움을 요청함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 안색에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G04. 샤워·목욕·세면·청결 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 안색·어지럼·숨참·피부 변화를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 어지럼·흉통·숨참는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 목욕 전 준비

목욕 전 준비입니다. 목욕 허용 여부, 이동 방법, 상처와 관 보호 지시를 확인합니다. 미끄럼 방지, 샤워 의자, 손잡이와 호출 방법을 점검하고 수건과 옷을 미리 둡니다. 물은 온도계와 병원 기준으로 확인하며 감각이 둔한 환자의 느낌만 믿지 않습니다. 어지럽거나 숨차면 전신 목욕 대신 부분 세정을 상의합니다.

03 / 씻기는 순서

씻기는 순서입니다. 얼굴과 상체 등 깨끗한 부위부터 씻고 회음부는 마지막에 별도 물품으로 닦습니다. 한 부위씩 노출하여 씻고 바로 덮어 추위와 수치심을 줄입니다. 환자가 할 수 있는 세면은 스스로 하게 하며, 긴 시간 서 있지 않도록 앉아서 쉬게 합니다. 이동 시 젖은 바닥과 관의 당김을 확인합니다.

04 / 중단해야 할 상황

중단해야 할 상황입니다. 창백함, 식은땀, 어지럼, 흉통, 숨참이 있으면 즉시 중단하고 안전하게 지지한 뒤 간호사를 부릅니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 비상 호출합니다. 환자를 욕실에 혼자 두지 않으며 관·산소·드레싱을 임의로 빼거나 물에 담그지 않습니다.

05 / 목욕 후 관리

목욕 후 관리입니다. 피부 주름과 발가락 사이를 부드럽게 말리고 피부 손상과 발적을 확인합니다. 보습제는 지시에 따르고 발가락 사이를 축축하게 남기지 않습니다. 옷과 침구를 정리하고 피로 정도를 확인합니다. 시행한 부위, 중단 이유, 피부 변화와 보고 내용을 기록합니다.

학습 메모

_____

_____

G04. 샤워·목욕·세면·청결 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Kiểm tra được tắm không, cách di chuyển, bảo vệ vết thương và ống. Kiểm tra chống trượt, ghế tắm, tay vịn và chuông; chuẩn bị khăn áo. Đo nhiệt độ nước theo quy định, không chỉ dựa vào cảm giác người giảm cảm giác. Nếu chóng mặt hoặc khó thở, hỏi về lau từng phần.

03

Rửa vùng sạch như mặt, thân trên trước; vùng kín cuối bằng đồ riêng. Chỉ để lộ từng vùng rồi che lại. Khuyến khích tự rửa mặt, ngồi nghỉ để tránh đứng lâu. Khi chuyển, kiểm tra sàn ướt và ống bị kéo.

04

Dừng ngay nếu tái, vã mồ hôi, chóng mặt, đau ngực hay khó thở; đỡ an toàn và gọi điều dưỡng. Khó thở nặng hoặc thay đổi ý thức: gọi khẩn. Không để một mình trong phòng tắm; không tự tháo hay ngâm ống, oxy, băng.

05

Thấm khô nếp da và kẽ ngón chân, kiểm tra đỏ hay tổn thương. Bôi dưỡng theo chỉ dẫn, không để kẽ chân ẩm. Chỉnh áo, ga và hỏi mức mệt. Ghi vùng đã làm, lý do dừng, thay đổi da và báo cáo.

G05. 이동·체위·침상·생활환경 지원

일반교육 | 계획 4시간 | 교안

설명·시연 1시간 / 연습·실습 2시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 이동·체위변경 계획과 도움 수준 확인 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 이동 전 점검

- 옮기기·돌리기

- 체위와 피부

- 낙상 후 대응

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 사례는 화장실 이동 요청입니다. 이동 계획 확인, 환경 준비, 협업 요청과 지원 후 관찰을 평가합니다. 아직 해결하지 못한 위험요인은 다음 근무자에게 전달합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G05 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 균형·통증·움직임·관의 당김입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

새 힘 빠짐·넘어짐·지속되는 발적 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 2시 일어서려 할 때 몸이 오른쪽으로 기울고 무릎에 힘이 없다고 말함. 이동을 중단하고 도움을 요청함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 균형에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G05. 이동·체위·침상·생활환경 지원

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 균형·통증·움직임·관의 당김를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 새 힘 빠짐·넘어짐·지속되는 발적는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 이동 전 점검

이동 전 점검입니다. 환자의 체중 지지 가능 여부, 마비, 통증, 어지럼과 필요한 인원을 확인합니다. 침대와 휠체어 브레이크를 잠그고 발판과 통로를 정리합니다. 신발은 미끄럽지 않고 발에 맞는 것으로 준비합니다. 기립은 천천히 진행하며 어지러우면 앉혀 쉬게 하고 간호사에게 알립니다.

03 / 옮기기·돌리기

옮기기·돌리기입니다. 침대에서 몸을 끌어당기지 말고 교육받은 이동 보조도구와 정해진 인원을 사용합니다. 겨드랑이, 마비 팔, 목이나 관을 잡아 들지 않습니다. 들어 올리는 리프트는 사용 교육을 이수한 담당자가 작동합니다. 이동 전 설명하고 구령을 맞추며 환자의 발과 관이 끼지 않는지 확인합니다.

04 / 체위와 피부

체위와 피부입니다. 체위변경 주기는 피부 상태와 돌봄계획에 맞춰 시행하고 시간을 기록합니다. 베개 등 지정 도구로 뼈 돌출 부위의 압박을 줄입니다. 뒤꿈치와 엉치, 귀, 관이 닿는 부위를 살피고 시트의 주름과 습기를 정리합니다. 붉은 피부를 마사지하거나 아픈 쪽으로 계속 눕히지 않습니다.

05 / 낙상 후 대응

낙상 후 대응입니다. 넘어지면 즉시 도움을 부르고 급히 일으키지 않습니다. 머리 충격, 통증, 출혈과 의식·호흡 상태를 확인해 전달합니다. 위험한 장소가 아니라면 의료진 평가 전 무리하게 옮기지 않습니다. 반응이 없고 정상 호흡이 없으면 비상 호출과 교육받은 심폐소생술 절차를 따릅니다.

학습 메모

_____

_____

G05. 이동·체위·침상·생활환경 지원

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Kiểm tra khả năng chịu trọng lượng, liệt, đau, chóng mặt và số người cần. Khóa giường, xe lăn; dọn bàn đạp và lối đi. Chuẩn bị giày vừa, chống trượt. Đứng lên chậm; nếu chóng mặt, cho ngồi nghỉ và báo điều dưỡng.

03

Không kéo lê trên giường; dùng dụng cụ và đủ người theo kế hoạch. Không nâng bằng nách, tay liệt, cổ hay ống. Máy nâng do người được đào tạo vận hành. Giải thích, phối hợp nhịp và tránh kẹt chân, ống.

04

Đổi tư thế theo da và kế hoạch, ghi giờ. Dùng gối hay dụng cụ được chỉ định giảm đè vùng xương. Quan sát gót, vùng cùng, tai và chỗ tì ống; làm phẳng, khô ga. Không xoa vùng đỏ hoặc tiếp tục nằm đè chỗ đau.

05

Nếu ngã, gọi hỗ trợ, không dựng dậy vội. Báo va đầu, đau, chảy máu, ý thức và thở. Không di chuyển ép trước đánh giá trừ nơi nguy hiểm. Không đáp ứng và không thở bình thường: gọi khẩn và làm hồi sức đã được đào tạo.

G06. 감염관리·손 위생·보호구

일반교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 손 위생 2시간 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 손 위생 시점

- 청결과 오염 구분

- 호흡기·환경 관리

- 노출 사고 대응

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 통합 실습에서는 한 환자를 돕고 다음 활동으로 넘어가는 흐름을 관찰합니다. 지침 확인, 손 위생, 물품 구분, 누락 발견 시 보고를 평가하고 부족한 부분은 다시 실습합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G06 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 오염 부위·손 위생 시점·노출 여부입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

체액 노출·찔림 사고·격리수칙 미준수 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 10시 배설물 처리 중 장갑이 찢어져 손에 오염이 묻음. 돌봄을 안전하게 멈추고 손을 씻은 뒤 담당자에게 알림.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 오염 부위에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G06. 감염관리·손 위생·보호구

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 오염 부위·손 위생 시점·노출 여부를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 체액 노출·찔림 사고·격리수칙 미준수는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 손 위생 시점

손 위생 시점입니다. 환자 접촉 전후, 청결한 돌봄 전, 체액·배설물 접촉 뒤, 주변 물품 접촉 뒤에 손 위생을 합니다. 장갑은 손 위생을 대신하지 않습니다. 눈에 보이는 오염은 물과 비누로 씻고, 격리환자는 병원의 지정 방법을 따릅니다. 휴대전화나 문손잡이를 만진 장갑으로 깨끗한 물품을 만지지 않습니다.

03 / 청결과 오염 구분

청결과 오염 구분입니다. 개인별 세면도구와 기구를 구분하고 다른 환자와 공유하지 않습니다. 깨끗한 물품을 먼저 준비하고 오염물은 지정 봉투에 담습니다. 오염된 장갑으로 병실을 돌아다니지 말고 벗은 뒤 손 위생을 합니다. 보호구는 격리 표지와 교육받은 착탈 순서를 따릅니다.

04 / 호흡기·환경 관리

호흡기·환경 관리입니다. 기침할 때 휴지나 팔꿈치 안쪽으로 가리고 사용 휴지는 바로 버립니다. 분무 치료는 병원 감염관리 지시에 맞는 장소와 보호구로 보조합니다. 침상 난간과 자주 만지는 표면은 지정된 세정·소독 방법을 따르며 소독제를 임의로 섞지 않습니다.

05 / 노출 사고 대응

노출 사고 대응입니다. 눈이나 피부에 체액이 튀거나 날카로운 물건에 찔리면 즉시 간호사에게 알리고 병원 노출 대응 절차를 따릅니다. 바늘을 손으로 다시 뚜껑 씌우거나 일반 쓰레기에 넣지 않습니다. 실습은 손 위생 시점 찾기, 오염 장갑 교체, 개인 기구 구분과 노출 보고를 평가합니다.

학습 메모

_____

_____

G06. 감염관리·손 위생·보호구

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Vệ sinh tay trước sau tiếp xúc, trước chăm sóc sạch, sau dịch cơ thể và đồ quanh bệnh nhân. Găng không thay vệ sinh tay. Bẩn thấy được: rửa nước xà phòng; cách ly theo phương pháp bệnh viện. Không chạm đồ sạch bằng găng đã chạm điện thoại hay tay cửa.

03

Tách dụng cụ cá nhân, không dùng chung. Chuẩn bị đồ sạch trước, bỏ đồ bẩn đúng túi. Không đi khắp phòng với găng bẩn; bỏ găng rồi vệ sinh tay. Mang, tháo bảo hộ theo biển cách ly và đào tạo.

04

Che ho bằng giấy hoặc khuỷu tay, bỏ giấy ngay. Hỗ trợ khí dung ở nơi và với bảo hộ đúng hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. Bề mặt hay chạm được vệ sinh theo quy trình; không tự trộn hóa chất.

05

Nếu dịch bắn vào mắt, da hoặc bị vật sắc đâm, báo ngay và theo quy trình phơi nhiễm. Không đậy lại kim bằng tay hay bỏ rác thường. Thực hành nhận biết lúc vệ sinh tay, đổi găng bẩn, tách dụng cụ và báo phơi nhiễm.

G07. 환자안전·낙상·피부손상·비상보고

일반교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 환자안전·비상 연락 2시간 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 환경 점검

- 피부손상 예방

- 응급 징후와 행동

- 기록과 모의훈련

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 평가는 위험 찾기, 간결한 보고, 개인정보 보호, 도움 요청으로 진행합니다. 기준을 충족하지 못한 항목은 보충 실습 후 재평가합니다. 일반교육을 먼저 확인한 뒤 전문교육에 참여합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

G07 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 의식·호흡·피부·주변 위험입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

낙상·새 마비·의식 변화 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

새벽 2시 침상 옆 바닥에 환자가 앉아 있는 것을 발견함. 급히 일으키지 않고 호출, 통증 호소를 전달함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 의식에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

G07. 환자안전·낙상·피부손상·비상보고

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 의식·호흡·피부·주변 위험를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 낙상·새 마비·의식 변화는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 환경 점검

환경 점검입니다. 근무 시작 때 호출벨, 야간 조명, 침상 높이와 브레이크, 통로와 바닥 물기를 확인합니다. 안경과 보청기, 신발을 준비하고 혼자 화장실로 서두르지 않도록 미리 배설 의사를 묻습니다. 낙상 위험이 있어도 임의로 묶거나 침상 난간으로 가두지 말고 개별 안전계획을 확인합니다.

03 / 피부손상 예방

피부손상 예방입니다. 엉치, 뒤꿈치, 팔꿈치와 의료기구가 닿는 피부를 관찰합니다. 씻어도 남는 발적, 색 변화, 물집과 통증은 보고합니다. 젖은 침구는 정리하고 체위변경은 개별 일정과 보조도구에 따릅니다. 붉은 부위를 세게 주무르거나 원형 방석을 임의로 사용하지 않습니다.

04 / 응급 징후와 행동

응급 징후와 행동입니다. 갑자기 심하게 숨차거나 입술이 파래짐, 새로 생긴 편측 마비·말 어눌함, 흉통, 의식 저하는 즉시 비상 호출합니다. 환자를 혼자 두지 않고 발생 시각을 기억합니다. 반응이 없고 정상 호흡이 없으면 병원 비상체계와 교육받은 심폐소생술·자동심장충격기 절차를 따릅니다.

05 / 기록과 모의훈련

기록과 모의훈련입니다. 도움을 요청할 때 병실·환자·증상을 먼저 말하고 지시를 다시 확인합니다. 사고 시각, 목격한 사실, 시행한 도움과 의료진 인계 시각을 기록합니다. 모의훈련은 낙상, 식사 중 질식, 갑작스러운 호흡곤란을 각각 연습하며 신고를 늦추는 행동을 찾아 고칩니다.

학습 메모

_____

_____

G07. 환자안전·낙상·피부손상·비상보고

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Đầu ca kiểm tra chuông, đèn, độ cao và khóa giường, lối đi, sàn ướt. Chuẩn bị kính, máy trợ thính, giày; hỏi nhu cầu vệ sinh sớm. Không tự trói hay giam bằng thanh chắn; theo kế hoạch an toàn riêng.

03

Quan sát vùng cùng, gót, khuỷu và nơi thiết bị tì. Báo đỏ kéo dài, đổi màu, phồng rộp, đau. Đổi ga ướt, đổi tư thế theo lịch và dụng cụ riêng. Không xoa mạnh vùng đỏ hay tự dùng đệm vòng.

04

Khó thở nặng đột ngột, môi tím, yếu một bên mới, nói khó, đau ngực hoặc giảm ý thức: gọi khẩn ngay. Không để một mình, nhớ thời điểm. Không đáp ứng và không thở bình thường: theo hệ thống cấp cứu, hồi sức và máy khử rung đã học.

05

Khi gọi, nói phòng, người bệnh, triệu chứng trước; xác nhận chỉ dẫn. Ghi giờ, sự việc thấy, hỗ trợ và lúc bàn giao. Luyện ngã, nghẹn và khó thở đột ngột riêng, sửa hành vi làm chậm gọi cứu.

S01. 피딩 환자: 경관영양 돌봄

전문교육 | 계획 10시간 | 교안

설명·시연 3시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 경관영양·비위관·위루관의 이해 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 시작 전 확인 / 자세와 준비 / 주입 중 이상 / 마무리 돌봄 / 경관영양·물 공급량 구분 / 교대 합계·누락·보고

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 모형 실습에서는 돌봄 전 계획 확인과 주변 안전, 이상 상황 발견 시 연락을 연습합니다. 평가 문항은 관이 빠져 보일 때 어떻게 행동하는가입니다. 임의 조작 없이 의료진에게 알리는지 확인합니다. 실습용 눈금컵과 저울로 제공량·잔량·용기 무게를 확인하고 실측·추정·측정 불가를 구분해 기록하는 과제를 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S01 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 기침·구토·복부 팽만·관 외부 변화입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

호흡 변화·구토·관 빠짐 의심 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 1시 주입 중 기침과 구역질이 나타남. 교육받은 중단 절차에 따르고 즉시 간호사를 부름.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 기침에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S01 섭취·배설 수치 기록 실습

모두 가상 계산 예시이며 정상량이나 환자별 목표가 아닙니다. 측정 방법·주기·보고 기준은 해당 병원 지시를 따릅니다. 식품용과 배설물용 도구를 구분합니다.

시간/구간	항목	측정 내역	기록할 수치	상태·측정 방법
08:00	물	제공 200 mL / 남음 80 mL	120 mL 섭취	눈금 실측·흘림 없음
08:10	죽	제공 200 g / 남음 50 g	150 g 섭취	용기 무게 제외·흘림 없음
08:00–10:00	소변	전용 눈금 용기	250 mL 배출	연한 노란색·통증 없음
10:20	대변	총 180 g / 용기 40 g	140 g / 1회	갈색·형성변·혈액 없음
12:00	기저귀 소변	젖음 280 g / 마름 30 g	약 250 mL 추정	소변만·누출 없음·병원 환산법
14:00	혼합 기저귀	소변·대변이 섞임	소변량 측정 불가	0 mL로 입력하지 않음

작성 연습

환자 / 날짜 / 시간·구간 / 음식·배설 종류 / 제공량 / 남은 양 / 흘린 양 / 실제량 / 단위 / 실측·추정·불가 / 색·형태·증상 / 작성자 / 보고 시각·대상 / 받은 지시

_____

_____

_____

S01. 피딩 환자: 경관영양 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 기침·구토·복부 팽만·관 외부 변화를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 호흡 변화·구토·관 빠짐 의심는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 시작 전 확인

시작 전 확인입니다. 경관영양은 코나 배의 관 종류, 위치 확인 완료 여부, 영양액·속도·물 주입 계획을 의료진에게 확인한 뒤 진행하는 치료입니다. 간병인은 허용된 보조 범위만 맡습니다. 관 위치를 공기 주입 소리로 판단하거나 빠진 관을 다시 넣지 않습니다. 금식 지시가 있으면 입으로 물이나 음식을 주지 않습니다.

03 / 자세와 준비

자세와 준비입니다. 금기가 없다면 상반신을 적어도 삼십 도에서 사십오 도 높이고 처방된 자세를 유지하도록 돕습니다. 관이 꺾이거나 몸에 눌리지 않는지 밖에서 살핍니다. 손 위생 후 지정 물품을 준비합니다. 연결, 위치 확인, 주입량·속도 설정과 약물 주입은 병원의 자격과 업무 지시에 따른 담당자가 합니다.

04 / 주입 중 이상

주입 중 이상입니다. 기침, 숨참, 구토, 심한 복부 팽만, 누출이나 관 길이 변화가 보이면 더 진행하지 말고 즉시 간호사를 부릅니다. 교육받은 중단 절차가 있으면 따릅니다. 경보를 반복 해제하거나 속도를 높이지 않습니다. 막힌 관에 탄산음료를 넣거나 힘으로 밀지 않습니다.

05 / 마무리 돌봄

마무리 돌봄입니다. 주입 후에도 개별 지시에 정한 시간 동안 상체를 높이고, 구강 위생과 관 주변 피부 관찰을 돕습니다. 설사·구토 횟수, 통증, 실제 공급량은 담당자 확인값으로 기록합니다. 실습은 자세 유지, 관 당김 방지, 이상 시 중단·보고이며 관 조작은 의료진의 감독 교육과 권한 확인이 필요합니다.

06 / 경관영양·물 공급량 구분

경관영양·물 공급량 구분입니다. 경관영양액과 관으로 공급한 물은 실제 주입된 양을 담당자가 확인한 밀리리터로 각각 기록합니다. 처방량, 준비량과 실제 들어간 양은 다를 수 있습니다. 중단·누출이 있으면 시각과 이유를 적고 펌프 수치를 임의로 조정하지 않습니다. 수액과 약물에 포함된 수분은 간호사가 관리하는 기록과 확인하며 이중으로 더하지 않습니다.

07 / 교대 합계·누락·보고

교대 합계·누락·보고입니다. 행마다 환자, 날짜·시각과 작성자를 확인하고 섭취·배출 직후 기록합니다. 교대나 병원이 정한 하루 구간에 밀리리터 항목끼리 합산합니다. 소변, 측정한 구토·액상 배출은 구분하고 음식·대변의 그램 기록과 섞지 않습니다. 측정하지 못함은 영이 아니므로 이유와 누락을 전달합니다. 수분 균형의 의미와 제한량 조정은 의료진이 판단합니다. 갑작스러운 소변 감소, 혈액, 검은 변, 반복 구토·설사는 합계 시간을 기다리지 말고 보고합니다.

학습 메모

_____

_____

S01. 피딩 환자: 경관영양 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Nuôi ăn qua ống cần nhân viên y tế xác nhận loại ống, vị trí, sữa, tốc độ và nước. Người chăm sóc chỉ hỗ trợ trong phạm vi cho phép. Không nghe bơm khí để tự xác nhận vị trí, không đặt lại ống tuột. Nhịn ăn: không cho nước hay thức ăn bằng miệng.

03

Nếu không chống chỉ định, hỗ trợ nâng thân trên ít nhất 30–45 độ theo kế hoạch. Quan sát ống ngoài có gập, đè không. Vệ sinh tay, chuẩn bị đồ. Nối ống, xác nhận vị trí, cài lượng tốc độ và thuốc do người có nhiệm vụ, năng lực phù hợp thực hiện.

04

Nếu ho, khó thở, nôn, chướng nhiều, rò hay chiều dài ống đổi, không tiếp tục và gọi điều dưỡng. Theo quy trình dừng đã học. Không liên tục tắt báo động hay tăng tốc. Không bơm nước có ga hay dùng lực thông ống.

05

Sau ăn giữ cao theo thời gian chỉ định, hỗ trợ vệ sinh miệng và quan sát da quanh ống. Ghi số lần tiêu chảy, nôn, đau và lượng thực tế do người phụ trách xác nhận. Luyện giữ tư thế, tránh kéo, dừng và báo; thao tác ống cần đào tạo giám sát và xác nhận quyền hạn.

06

Ghi riêng mL sữa qua ống và nước thực vào do người phụ trách xác nhận. Lượng kê, chuẩn bị và thực vào có thể khác. Ghi giờ, lý do dừng hay rò, không tự chỉnh bơm. Dịch truyền, nước trong thuốc đối chiếu với điều dưỡng, không cộng trùng.

07

Xác nhận người, ngày giờ, người ghi; ghi ngay sau ăn uống, bài tiết. Cộng các mục mL theo ca hay khoảng ngày viện quy định. Tách tiểu, nôn đo được, dịch lỏng; không trộn với g thức ăn, phân. Không đo được không phải số 0; bàn giao lý do, thiếu. Y tế đánh giá cân bằng và điều chỉnh. Tiểu giảm đột ngột, máu, phân đen, nôn tiêu chảy lặp phải báo ngay.

S02. 소변줄 환자: 유치도뇨관 돌봄

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 도뇨관·소변주머니의 이해와 개별 지시 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 기본 배치 / 청결·비우기 보조 / 관찰과 보고 / 금지 행동·실습 / 소변·시간·양·색 기록 / 기저귀 무게·추정값 구분 / 교대 합계·누락·보고 / 눈금컵으로 양 읽기

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 모형을 사용해 이동 전 확인과 보고를 연습합니다. 소변이 나오지 않는 사례에서 임의로 연결을 풀지 않고 관찰한 사실과 시간을 전달하는지 평가합니다. 실습용 눈금컵과 저울로 제공량·잔량·용기 무게를 확인하고 실측·추정·측정 불가를 구분해 기록하는 과제를 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S02 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 소변의 양·색·누출·통증입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

갑작스러운 배출 감소·혈뇨·발열·통증 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 3시 평소와 달리 주머니에 소변이 거의 없고 아랫배가 아프다고 말함. 보이는 관 눌림을 확인하고 즉시 알림.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 소변의 양에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S02 섭취·배설 수치 기록 실습

모두 가상 계산 예시이며 정상량이나 환자별 목표가 아닙니다. 측정 방법·주기·보고 기준은 해당 병원 지시를 따릅니다. 식품용과 배설물용 도구를 구분합니다.

시간/구간	항목	측정 내역	기록할 수치	상태·측정 방법
08:00	물	제공 200 mL / 남음 80 mL	120 mL 섭취	눈금 실측·흘림 없음
08:10	죽	제공 200 g / 남음 50 g	150 g 섭취	용기 무게 제외·흘림 없음
08:00–10:00	소변	전용 눈금 용기	250 mL 배출	연한 노란색·통증 없음
10:20	대변	총 180 g / 용기 40 g	140 g / 1회	갈색·형성변·혈액 없음
12:00	기저귀 소변	젖음 280 g / 마름 30 g	약 250 mL 추정	소변만·누출 없음·병원 환산법
14:00	혼합 기저귀	소변·대변이 섞임	소변량 측정 불가	0 mL로 입력하지 않음

작성 연습

환자 / 날짜 / 시간·구간 / 음식·배설 종류 / 제공량 / 남은 양 / 흘린 양 / 실제량 / 단위 / 실측·추정·불가 / 색·형태·증상 / 작성자 / 보고 시각·대상 / 받은 지시

_____

_____

_____

S02. 소변줄 환자: 유치도뇨관 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 소변의 양·색·누출·통증를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 갑작스러운 배출 감소·혈뇨·발열·통증는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 기본 배치

기본 배치입니다. 소변주머니는 방광보다 낮게, 바닥에는 닿지 않게 둡니다. 관이 허벅지나 침상에 눌리거나 꺾이지 않게 하고 이동할 때 당겨지지 않을 여유를 둡니다. 주머니를 침상 위에 올리거나 관과 주머니 연결을 불필요하게 분리하지 않습니다.

03 / 청결·비우기 보조

청결·비우기 보조입니다. 손 위생과 장갑 착용 후 회음부를 병원 지침에 따라 부드럽게 씻고 말립니다. 주머니 비우기는 교육과 업무 지시가 있는 경우 전용 용기로 시행하고 배출구가 용기나 바닥에 닿지 않게 합니다. 가득 찰 때까지 기다리지 말고 계획에 따른 시점에 담당자에게 요청합니다.

04 / 관찰과 보고

관찰과 보고입니다. 소변량과 색, 혈액·침전, 누출, 아랫배 통증, 발열과 오한을 관찰합니다. 소변이 갑자기 나오지 않으면 눈에 보이는 관 눌림을 확인하고 바로 간호사에게 알립니다. 수분은 심장·신장 상태에 따른 제한을 확인하며 임의로 많이 먹이지 않습니다.

05 / 금지 행동·실습

금지 행동·실습입니다. 관을 빼거나 다시 넣기, 풍선 조절, 세척액 주입은 간병인이 독자적으로 하지 않습니다. 빠진 관은 바로 보고하고 재삽입을 시도하지 않습니다. 실습에서는 주머니 높이, 꺾임, 이동 시 당김, 배출구 오염을 찾아 수정하고 보고 문장을 연습합니다.

06 / 소변·시간·양·색 기록

소변·시간·양·색 기록입니다. 소변은 병원에서 지정한 눈금 용기와 방법으로 측정하고 밀리리터로 적습니다. 날짜·시각, 측정한 구간, 양, 색·탁도·혈액 여부와 통증을 기록합니다. 예를 들어 오전 여덟 시부터 열 시까지 이백오십 밀리리터, 연한 노란색, 통증 없음이라고 적습니다. 같은 소변을 주머니 눈금과 비운 양으로 두 번 합산하지 않습니다. 측정하려고 관 연결을 분리하지 않습니다.

07 / 기저귀 무게·추정값 구분

기저귀 무게·추정값 구분입니다. 병원이 기저귀 계량법을 정한 경우에만 동일 제품의 마른 기저귀 무게를 뺍니다. 젖은 무게 이백팔십 그램에서 마른 무게 삼십 그램을 빼면 증가분은 이백오십 그램입니다. 소변만 포함되고 누출이 없을 때 병원 기준에 따라 약 이백오십 밀리리터로 추정했다고 표시합니다. 대변·세정액이 섞이거나 누출되면 정확한 소변량으로 환산하지 말고 혼합 또는 측정 불가와 이유를 적습니다.

08 / 교대 합계·누락·보고

교대 합계·누락·보고입니다. 행마다 환자, 날짜·시각과 작성자를 확인하고 섭취·배출 직후 기록합니다. 교대나 병원이 정한 하루 구간에 밀리리터 항목끼리 합산합니다. 소변, 측정한 구토·액상 배출은 구분하고 음식·대변의 그램 기록과 섞지 않습니다. 측정하지 못함은 영이 아니므로 이유와 누락을 전달합니다. 수분 균형의 의미와 제한량 조정은 의료진이 판단합니다. 갑작스러운 소변 감소, 혈액, 검은 변, 반복 구토·설사는 합계 시간을 기다리지 말고 보고합니다.

09 / 눈금컵으로 양 읽기

눈금컵으로 양 읽기입니다. 물과 음료는 눈금이 있는 식품용 컵에, 소변은 별도의 전용 눈금 용기에 담아 측정합니다. 평평한 곳에 두고 액면과 눈높이를 맞춰 밀리리터 눈금을 읽습니다. 용기 용량을 확인하고 넘침·흘림·남은 양을 구분합니다. 읽을 수 없는 눈금은 추측하지 않습니다. 정확한 소변 계량을 위해 관 연결을 분리하지 말고 병원이 정한 방법을 따릅니다.

학습 메모

_____

_____

S02. 소변줄 환자: 유치도뇨관 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Đặt túi thấp hơn bàng quang, không chạm sàn. Tránh ống bị đè, gập; chừa độ dài khi chuyển. Không đặt túi lên giường hay tháo mối nối không cần thiết.

03

Vệ sinh tay, đeo găng, rửa nhẹ và làm khô vùng kín theo quy trình. Chỉ xả túi khi được đào tạo, phân công; dùng đồ riêng và tránh đầu xả chạm đồ chứa hay sàn. Không chờ đầy, yêu cầu người phụ trách theo lịch.

04

Quan sát lượng, màu, máu, cặn, rò, đau bụng dưới, sốt, rét run. Nếu đột ngột không ra, nhìn xem bị đè rồi báo ngay. Nước theo giới hạn tim, thận; không tự ép uống nhiều.

05

Không tự rút, đặt lại, chỉnh bóng hay bơm rửa ống. Tuột ống: báo ngay, không thử đặt lại. Thực hành tìm sai về độ cao túi, gập, kéo và nhiễm bẩn đầu xả, rồi luyện báo cáo.

06

Đo nước tiểu bằng dụng cụ chia vạch, cách viện chỉ định, ghi mL. Ghi ngày giờ, khoảng đo, lượng, màu, độ đục, máu, đau. Ví dụ 08–10 giờ: 250 mL, vàng nhạt, không đau. Không cộng hai lần cùng lượng từ vạch túi và lượng đã xả. Không tháo nối chỉ để đo.

07

Chỉ cân tã theo quy trình viện, trừ tã khô cùng loại. 280 g ướt trừ 30 g khô = tăng 250 g. Nếu chỉ có nước tiểu, không rò, ghi ước tính khoảng 250 mL theo viện. Có phân, nước rửa, rò thì không đổi thành nước tiểu chính xác; ghi lẫn hoặc không đo được và lý do.

08

Xác nhận người, ngày giờ, người ghi; ghi ngay sau ăn uống, bài tiết. Cộng các mục mL theo ca hay khoảng ngày viện quy định. Tách tiểu, nôn đo được, dịch lỏng; không trộn với g thức ăn, phân. Không đo được không phải số 0; bàn giao lý do, thiếu. Y tế đánh giá cân bằng và điều chỉnh. Tiểu giảm đột ngột, máu, phân đen, nôn tiêu chảy lặp phải báo ngay.

09

Đo nước uống bằng cốc thực phẩm chia vạch, nước tiểu bằng dụng cụ riêng. Đặt phẳng, mắt ngang mặt dịch, đọc mL. Kiểm tra dung tích, tách phần tràn, đổ, còn. Không đoán vạch không đọc được. Không tháo nối ống để đo; theo cách viện quy định.

S03. 폐질환 환자·호흡 불편 돌봄

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 호흡 불편·피로를 고려한 일상생활 지원 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

질환과 돌봄 단계 / 호흡곤란·응급 구분 / 숨찰 때 자세·초기 보조 / 폐렴·급성기 돌봄 / 폐렴·식사와 회복기 / 폐색전증·폐경색 의심 시 / 폐색전증·치료 후 돌봄 / 폐암·수술 후 단계 / 폐암·약물·방사선 치료 단계 / 폐암·진행성·완화 단계 / 네뷸라이저·사용 전 / 네뷸라이저·사용 중 / 네뷸라이저·사용 후와 금지사항 / 산소·관찰·보고 실습

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 사례 실습은 세면 중 숨참을 호소하는 상황입니다. 활동을 무리하게 계속하지 않고 환자 곁에서 도움을 요청하며 관찰 사실을 전달하는지 평가합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S03 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 숨찬 정도·말하기·안색·기침·가래·의식입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

새롭거나 악화된 숨참·흉통·객혈·혼돈 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 2시 세면 중 평소보다 숨차다고 말하고 문장을 끝내기 어려워함. 세면을 멈추고 비상 호출 후 허용된 앉은 자세를 지지함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 숨찬 정도에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S03. 폐질환 환자·호흡 불편 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 숨찬 정도·말하기·안색·기침·가래·의식를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 새롭거나 악화된 숨참·흉통·객혈·혼돈는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 질환과 돌봄 단계

질환과 돌봄 단계입니다. 폐렴은 폐의 감염이며, 폐경색은 폐혈관이 막혀 폐조직 일부가 손상된 상태입니다. 폐색전증과 함께 나타날 수 있지만 같은 말은 아닙니다. 폐암은 암의 병기뿐 아니라 수술 여부, 치료 부작용, 호흡 상태에 따라 돌봄이 달라집니다. 간병인은 진단하지 않고 의료진이 정한 급성기·치료기·회복기 계획을 확인합니다.

03 / 호흡곤란·응급 구분

호흡곤란·응급 구분입니다. 갑자기 심하게 숨차거나 한 문장을 말하기 어렵고, 흉통·입술의 청색 변화·실신·새로운 혼돈·객혈이 있으면 즉시 병원 비상 호출을 합니다. 병원 밖이면 한국에서는 백십구입니다. 산소포화도가 정상으로 보여도 신고를 미루지 않습니다. 반응이 없고 정상 호흡이 없으면 교육받은 심폐소생술 절차를 따릅니다.

04 / 숨찰 때 자세·초기 보조

숨찰 때 자세·초기 보조입니다. 의식이 있고 자세 변경이 허용되면 활동을 멈추고 침상 상체를 올려 머리·등·팔을 베개로 지지합니다. 앉을 수 있다면 탁자나 베개에 팔을 받치고 몸을 약간 앞으로 기대게 할 수 있습니다. 편안한 자세를 물으며 억지로 눕히지 않습니다. 실신하거나 외상이 의심되면 무조건 앉히지 말고 비상 지시를 따릅니다.

05 / 폐렴·급성기 돌봄

폐렴·급성기 돌봄입니다. 열·오한, 기침과 가래의 변화, 숨찬 정도, 의식과 식사량을 평소와 비교해 기록합니다. 검사와 항생제·산소 치료는 의료진이 시행합니다. 간병인은 휴식 시간을 확보하고 지정된 감염 예방수칙과 구강 위생을 돕습니다. 힘들게 기침시키거나 흉부를 두드리는 처치를 임의로 하지 않습니다.

06 / 폐렴·식사와 회복기

폐렴·식사와 회복기입니다. 숨이 안정되고 삼킴이 허용된 때 앉은 자세에서 적은 양을 천천히 먹도록 돕습니다. 물은 심부전·신장질환의 제한을 확인해 정해진 양으로 제공합니다. 기침·젖은 목소리·숨참이 생기면 식사를 멈춥니다. 회복기에는 허용된 짧은 이동과 휴식을 번갈아 하며, 다시 열이 나거나 더 숨차면 재평가를 요청합니다.

07 / 폐색전증·폐경색 의심 시

폐색전증·폐경색 의심 시입니다. 갑자기 발생한 호흡곤란, 숨쉴 때의 흉통, 객혈이나 실신은 응급 평가가 필요합니다. 걷게 해서 풀거나 다리를 마사지하지 말고 비상 호출 후 곁에 머뭅니다. 네뷸라이저를 먼저 해 보고 기다리는 방식으로 대응하지 않습니다. 발생 시각과 복용 중인 약 정보를 의료진에게 전달합니다.

08 / 폐색전증·치료 후 돌봄

폐색전증·치료 후 돌봄입니다. 항응고제 치료 중에는 코피·잇몸 출혈, 혈뇨·검은 변, 커지는 멍을 보고합니다. 넘어지거나 머리를 부딪힌 경우 겉으로 괜찮아도 즉시 알립니다. 약을 임의로 중단하거나 추가하지 않습니다. 안정 뒤 이동은 의료진 허용 범위에서 단계적으로 돕고, 새 흉통·숨참·실신은 즉시 비상 대응합니다.

09 / 폐암·수술 후 단계

폐암·수술 후 단계입니다. 수술 부위 통증, 호흡 변화와 피로를 묻고 자세변경·기침·보행은 수술팀 계획에 맞춰 보조합니다. 흉관이 있으면 관을 잡아당기거나 잠그지 않고 배액 장치 위치와 이동 방법을 간호사에게 확인합니다. 갑작스러운 숨참, 출혈이나 관 분리는 즉시 알립니다. 통증 때문에 움직이지 못하면 약을 임의로 더 주지 말고 보고합니다.

10 / 폐암·약물·방사선 치료 단계

폐암·약물·방사선 치료 단계입니다. 식사량, 구토·설사, 입안 통증과 피로를 기록하고 쉬는 시간을 나눕니다. 항암치료 중 삼십팔 도 이상 발열 또는 병원이 정한 더 낮은 기준의 열·오한은 즉시 보고하며 해열제로 덮고 기다리지 않습니다. 면역치료·방사선 치료 중 새 기침이나 숨참도 단순 감기로 판단하지 않고 즉시 의료진에게 알립니다.

11 / 폐암·진행성·완화 단계

폐암·진행성·완화 단계입니다. 세면·식사·이동을 짧게 나누고 사이에 쉬도록 돕습니다. 편안한 상체 지지, 구강 건조 관리, 조용한 환경과 불안 경청을 제공합니다. 호흡곤란과 통증은 참게 하지 말고 완화의료팀에 전달합니다. 음식·물·활동을 억지로 권하지 않고 환자의 바람과 치료계획을 따릅니다. 진행성 암이라고 모든 새 증상을 방치하지 않습니다.

12 / 네뷸라이저·사용 전

네뷸라이저·사용 전입니다. 네뷸라이저는 처방 약액을 안개로 만들어 흡입하도록 하는 장치이며 모든 폐질환에 일괄 사용하는 기구는 아닙니다. 간호사가 환자·처방 약·용량·알레르기를 확인합니다. 간병인은 교육받고 허용된 범위에서 손 위생, 개인 전용 기구 준비, 편안한 앉은 자세와 전원·연결 상태 확인을 보조합니다.

13 / 네뷸라이저·사용 중

네뷸라이저·사용 중입니다. 담당자가 준비한 약액과 제조사 설명서에 맞춰 작동합니다. 약통은 세워 두고 마우스피스를 입술로 감싸 입으로 편안히 호흡하거나, 지정 마스크를 코와 입에 맞춥니다. 대화와 식사는 쉬고 곁에서 상태를 살핍니다. 더 숨참, 흉통, 심한 두근거림, 어지럼이 생기면 중단하고 즉시 간호사를 부릅니다.

14 / 네뷸라이저·사용 후와 금지사항

네뷸라이저·사용 후와 금지사항입니다. 종료 시점은 기종과 처방 지시에 따릅니다. 스테로이드 약제 사용 뒤에는 안전하게 헹굴 수 있는 환자의 입 헹굼과 뱉기를 돕고, 마스크 부위는 지시에 따라 닦습니다. 약통·마스크는 병원과 제조사 방법으로 세척·소독·완전 건조합니다. 공기 호스·본체를 임의로 물에 담그거나 약을 혼합·희석·증량하지 않습니다.

15 / 산소·관찰·보고 실습

산소·관찰·보고 실습입니다. 처방된 산소 유량을 임의로 바꾸지 않습니다. 관의 꺾임·빠짐을 보고하고 불꽃·흡연을 금지합니다. 산소포화도는 개별 목표와 보고 기준을 따르며 숫자보다 환자의 증상도 함께 봅니다. 실습은 숨참 발견, 활동 중단, 허용된 자세 지지, 비상 여부 판단과 보고, 네뷸라이저 전후 점검을 순서대로 합니다.

학습 메모

_____

_____

S03. 폐질환 환자·호흡 불편 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Viêm phổi là nhiễm trùng phổi; nhồi máu phổi là tổn thương mô do tắc mạch, có thể đi cùng thuyên tắc phổi nhưng không đồng nghĩa. Chăm sóc ung thư phổi phụ thuộc phẫu thuật, tác dụng phụ và hô hấp, không chỉ giai đoạn. Không tự chẩn đoán; kiểm tra kế hoạch cấp tính, điều trị, hồi phục.

03

Khó thở nặng đột ngột, khó nói cả câu, đau ngực, môi tím, ngất, lú lẫn mới hoặc ho máu: gọi cấp cứu bệnh viện ngay; ngoài viện ở Hàn Quốc gọi 119. Không chờ vì máy đo oxy có vẻ bình thường. Không đáp ứng, không thở bình thường: hồi sức theo đào tạo.

04

Nếu tỉnh và được đổi tư thế, dừng hoạt động, nâng đầu giường, đỡ đầu lưng tay bằng gối. Nếu ngồi được, có thể tựa tay trên bàn hay gối và hơi nghiêng trước. Hỏi tư thế dễ chịu, không ép nằm. Ngất hay nghi chấn thương: không mặc định dựng ngồi, theo chỉ dẫn khẩn.

05

So với thường ngày, ghi sốt rét run, ho đờm, khó thở, ý thức và ăn. Xét nghiệm, kháng sinh, oxy do y tế thực hiện. Hỗ trợ nghỉ, phòng nhiễm và vệ sinh miệng. Không tự ép ho mạnh hay vỗ ngực.

06

Khi thở ổn, được nuốt, giúp ăn ít chậm ở tư thế ngồi. Nước theo giới hạn tim, thận. Ho, giọng ướt hay khó thở thì dừng ăn. Hồi phục: xen kẽ vận động ngắn được phép và nghỉ; sốt lại hoặc khó thở tăng cần đánh giá lại.

07

Khó thở đột ngột, đau ngực khi thở, ho máu hay ngất cần đánh giá khẩn. Không bắt đi để đỡ hay xoa chân; gọi khẩn và ở bên. Không thử khí dung rồi chờ. Báo thời điểm và thông tin thuốc đang dùng.

08

Khi dùng chống đông, báo chảy máu mũi lợi, tiểu máu, phân đen, bầm tăng. Ngã hay va đầu phải báo ngay dù ngoài có vẻ ổn. Không tự dừng hoặc thêm thuốc. Khi ổn, hỗ trợ vận động tăng dần theo phép; đau ngực, khó thở, ngất mới phải cấp cứu.

09

Sau mổ hỏi đau, thay đổi thở, mệt; giúp đổi tư thế, ho, đi theo kế hoạch phẫu thuật. Có dẫn lưu ngực: không kéo, kẹp; hỏi điều dưỡng vị trí và cách chuyển. Báo khó thở đột ngột, máu hay tuột nối. Không tự thêm thuốc khi đau cản vận động.

10

Ghi ăn, nôn tiêu chảy, đau miệng và mệt; chia thời gian nghỉ. Trong hóa trị, sốt từ 38 độ hoặc ngưỡng thấp hơn của viện, rét run: báo ngay, không dùng hạ sốt rồi chờ. Ho hay khó thở mới khi miễn dịch hoặc xạ trị cũng phải báo, không tự cho là cảm.

11

Chia rửa, ăn, di chuyển thành đoạn ngắn có nghỉ. Đỡ thân thoải mái, chăm sóc miệng khô, môi trường yên và lắng nghe lo âu. Báo khó thở, đau cho nhóm giảm nhẹ. Không ép ăn uống, vận động; theo mong muốn và kế hoạch. Không bỏ qua triệu chứng mới vì ung thư tiến triển.

12

Máy khí dung biến dung dịch kê đơn thành sương để hít, không dùng chung cho mọi bệnh phổi. Điều dưỡng kiểm tra đúng người, thuốc, liều, dị ứng. Trong phạm vi được đào tạo, hỗ trợ vệ sinh tay, đồ riêng, ngồi thoải mái và kiểm tra điện, nối.

13

Vận hành theo dung dịch người phụ trách chuẩn bị và hướng dẫn máy. Giữ cốc thẳng, ngậm kín đầu và thở miệng bình thường, hoặc đặt mặt nạ đúng mũi miệng. Tạm ngừng nói ăn, theo dõi cạnh bên. Khó thở tăng, đau ngực, hồi hộp nhiều, chóng mặt: dừng và gọi điều dưỡng ngay.

14

Kết thúc theo máy và chỉ định. Sau steroid, giúp người nuốt an toàn súc rồi nhổ, lau vùng mặt nạ theo chỉ dẫn. Rửa, khử khuẩn, làm khô cốc và mặt nạ theo viện, hãng. Không tự ngâm dây khí, máy, trộn, pha hay tăng thuốc.

15

Không tự đổi lưu lượng oxy. Báo dây gập, tuột; tránh lửa và hút thuốc. Theo mục tiêu oxy và ngưỡng báo riêng, quan sát cả triệu chứng. Luyện nhận khó thở, dừng hoạt động, đỡ tư thế được phép, gọi khẩn hay báo, kiểm tra trước sau khí dung.

S04. 치매 환자·인지·행동 변화 돌봄

전문교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 4시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 존중하는 의사소통·일정·선호 이해 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 안정된 일상

- 거절·불안 대응

- 식사·진행 단계

- 기록·실습

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 목욕 거절과 반복 질문 사례입니다. 짧은 설명, 충분한 기다림, 감정 인정, 담당자와 대안 찾기를 평가합니다. 가족이 알려준 선호도 업무에 필요한 범위에서만 공유합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S04 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 말·표정·행동 변화와 직전 상황입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

갑작스러운 혼돈·졸림·발열·통증 행동 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 6시 평소와 달리 이름을 불러도 대답이 늦고 졸림이 심함. 치매 증상으로 단정하지 않고 즉시 보고함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 말에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S04. 치매 환자·인지·행동 변화 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 말·표정·행동 변화와 직전 상황를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 갑작스러운 혼돈·졸림·발열·통증 행동는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 안정된 일상

안정된 일상입니다. 정면에서 눈높이를 맞추고 이름과 할 일을 짧게 말합니다. 보청기·안경을 확인하고 한 번에 하나씩 안내합니다. 식사·세면·배설 시간을 익숙하게 유지하고 답을 기다립니다. 기억을 시험하거나 틀렸다고 논쟁하지 않습니다.

03 / 거절·불안 대응

거절·불안 대응입니다. 목욕이나 기저귀 교환을 거절하면 잠시 멈추고 통증, 추위, 배고픔과 배설 욕구를 확인합니다. 두 가지 간단한 선택지를 주고 익숙한 담당자와 다시 시도합니다. 소음을 줄이며 강제로 붙잡거나 위협하지 않습니다. 배회는 안전한 동행과 환경 정리로 돕습니다.

04 / 식사·진행 단계

식사·진행 단계입니다. 도구 사용이 어려우면 한 동작씩 보여 주고 가능한 부분은 직접 하게 합니다. 삼킴이 떨어지면 음식 질감과 도움 수준을 재평가받습니다. 늦은 단계에는 말보다 표정, 신음, 몸을 피하는 반응으로 통증을 관찰합니다. 급격한 혼돈·졸림·발열은 치매 탓으로 넘기지 않고 즉시 보고합니다.

05 / 기록·실습

기록·실습입니다. 불안 행동 전 상황, 행동, 대응과 결과를 구체적으로 적습니다. 예를 들어 저녁 목욕 제안 때 소리를 질러 방을 따뜻하게 하고 세면만 제안하니 동의했다고 기록합니다. 실습은 짧은 지시, 선택지 제시, 통증 확인과 갑작스러운 변화 보고를 평가합니다.

학습 메모

_____

_____

S04. 치매 환자·인지·행동 변화 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Đến từ phía trước, ngang mắt, nói tên và việc ngắn. Kiểm tra kính, máy trợ thính, hướng dẫn từng bước. Giữ giờ ăn rửa vệ sinh quen thuộc và chờ. Không kiểm tra trí nhớ hay tranh cãi đúng sai.

03

Nếu từ chối tắm, thay tã, dừng và kiểm tra đau, lạnh, đói, nhu cầu vệ sinh. Cho hai lựa chọn đơn giản, thử lại cùng người quen. Giảm ồn, không giữ ép, đe dọa. Hỗ trợ đi lại bằng đồng hành an toàn và dọn môi trường.

04

Khó dùng đồ thì làm mẫu từng bước và để tự làm phần có thể. Nuốt giảm cần đánh giá lại dạng ăn và hỗ trợ. Giai đoạn muộn quan sát đau qua mặt, rên, né tránh. Lú lẫn, buồn ngủ, sốt đột ngột không quy hết cho sa sút trí tuệ, báo ngay.

05

Ghi hoàn cảnh trước hành vi, hành vi, xử trí, kết quả. Ví dụ phản đối tắm tối, sau làm ấm phòng và đề nghị chỉ rửa mặt thì đồng ý. Luyện chỉ dẫn ngắn, lựa chọn, kiểm tra đau và báo thay đổi đột ngột.

S05. 뇌질환 환자·뇌졸중 후 돌봄

전문교육 | 계획 8시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 4시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 마비·언어·인지·삼킴 어려움과 지원 계획 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 급성 변화

- 마비·이동 보조

- 삼킴·의사소통

- 경련·회복기

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 표현이 어려운 환자의 요청을 확인하고 보고하는 역할극입니다. 고개 끄덕임이나 그림 등 병원에서 안내한 의사소통 방법을 활용하고 환자의 뜻을 추측으로 확정하지 않는지 평가합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S05 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 얼굴·말·팔다리 힘·삼킴·경련입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

새 마비·말 변화·경련·의식 저하 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 9시 10분 새로 말이 어눌하고 왼팔을 들지 못함. 비상 호출하고 마지막으로 평소 상태였던 시각이 9시임을 전달함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 얼굴에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S05. 뇌질환 환자·뇌졸중 후 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 얼굴·말·팔다리 힘·삼킴·경련를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 새 마비·말 변화·경련·의식 저하는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 급성 변화

급성 변화입니다. 얼굴 한쪽 처짐, 한쪽 팔·다리 힘 빠짐, 갑자기 말이 어눌해지거나 심한 두통·의식 변화가 생기면 비상 호출합니다. 마지막으로 정상이었던 시각을 전달합니다. 음식·물·약을 입으로 주거나 증상이 좋아질 때까지 기다리지 않습니다.

03 / 마비·이동 보조

마비·이동 보조입니다. 마비된 팔은 베개 등으로 지지하고 잡아당기지 않습니다. 재활팀이 정한 방향과 도구, 인원에 따라 이동합니다. 감각이 둔한 쪽 피부와 관의 눌림을 살피고 옷을 입히는 방법도 개별 재활 교육에 맞춥니다. 무리하게 관절을 꺾거나 운동량을 늘리지 않습니다.

04 / 삼킴·의사소통

삼킴·의사소통입니다. 식사 전 삼킴 허용 여부와 음식 질감을 확인합니다. 앉은 자세를 지지하고 한 입씩 기다리며 기침이나 젖은 목소리는 중단·보고합니다. 말을 못 해도 이해하지 못한다고 단정하지 말고 예·아니오 질문, 그림판과 충분한 응답 시간을 제공합니다.

05 / 경련·회복기

경련·회복기입니다. 경련하면 주변 위험물을 치우고 머리를 다치지 않게 보호하며 시간을 재고 즉시 도움을 부릅니다. 몸을 억지로 누르거나 입안에 물건·물을 넣지 않습니다. 회복기의 피로와 통증, 수행한 활동을 기록하며 실습은 마비 팔 보호, 삼킴 확인과 경련 상황의 안전 확보를 평가합니다.

학습 메모

_____

_____

S05. 뇌질환 환자·뇌졸중 후 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Méo mặt một bên, yếu tay chân, nói khó đột ngột, đau đầu nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn. Báo lúc cuối còn bình thường. Không cho ăn nước thuốc bằng miệng hoặc chờ tự đỡ.

03

Đỡ tay liệt bằng gối, không kéo. Chuyển theo hướng, dụng cụ và người của nhóm phục hồi. Quan sát da và ống bên giảm cảm giác, mặc áo theo hướng dẫn riêng. Không bẻ khớp hoặc tự tăng tập.

04

Kiểm tra được nuốt và dạng ăn, đỡ ngồi, chờ từng miếng; ho, giọng ướt thì dừng báo. Không cho rằng không hiểu vì không nói được; dùng câu có/không, bảng hình và thời gian trả lời.

05

Co giật: dọn vật nguy hiểm, bảo vệ đầu, tính giờ, gọi hỗ trợ ngay. Không ghì hoặc đưa đồ, nước vào miệng. Ghi mệt, đau, hoạt động lúc hồi phục; luyện bảo vệ tay liệt, kiểm tra nuốt và an toàn khi co giật.

S06. 파킨슨 환자·움직임·생활 지원

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 느린 움직임·보행 멈춤·균형 변화 이해 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 복약 시간과 일상

- 발이 붙는 느낌·보행

- 일어나기·식사

- 악화·평가

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습에서는 천천히 움직이는 환자에게 설명하고 기다리는 태도, 개별 이동 계획 확인, 식사 중 이상 보고를 평가합니다. 운동이나 약물 치료는 의료진의 계획을 따릅니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S06 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 움직임·멈춤·어지럼과 약 시간의 관계입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

갑작스러운 운동 악화·낙상·삼킴 악화 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 10시 문턱 앞에서 발을 떼지 못함. 잡아당기지 않고 균형을 지지하며 교육받은 구령으로 도움. 반복되어 보고함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 움직임에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S06. 파킨슨 환자·움직임·생활 지원

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 움직임·멈춤·어지럼과 약 시간의 관계를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 갑작스러운 운동 악화·낙상·삼킴 악화는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 복약 시간과 일상

복약 시간과 일상입니다. 파킨슨병은 약효에 따라 움직임이 달라질 수 있으므로 정해진 투약 시간이 지켜지도록 간호사에게 확인합니다. 식사·목욕은 움직임이 비교적 편한 시간과 휴식을 고려해 배치합니다. 약을 임의로 늦추거나 분쇄하지 않습니다.

03 / 발이 붙는 느낌·보행

발이 붙는 느낌·보행입니다. 발이 바닥에 붙은 듯 멈추면 재촉하거나 당기지 말고 안전하게 멈춰 균형을 잡도록 돕습니다. 재활팀이 가르친 구령이나 바닥 표시 같은 단서를 사용합니다. 급히 방향을 틀지 않고 넓게 돌아가며 좁은 통로의 물건을 치웁니다.

04 / 일어나기·식사

일어나기·식사입니다. 침상에서 일어날 때 천천히 앉아 어지럼을 확인한 뒤 정해진 보조로 섭니다. 갑자기 일으키지 않습니다. 식사는 삼킴 지시에 맞추고 충분한 시간을 줍니다. 기침·침 흘림·체중 감소나 변비가 지속되면 기록해 담당자에게 전달합니다.

05 / 악화·평가

악화·평가입니다. 평소보다 갑자기 움직이지 못하거나 심한 졸림·혼돈이 생기면 즉시 보고합니다. 넘어짐, 환각이나 삼킴 악화를 혼자 해결하지 않습니다. 실습은 약 시간 확인, 멈춤 현상 때 기다리기, 천천히 일어나기와 좁은 길 정리를 평가합니다.

학습 메모

_____

_____

S06. 파킨슨 환자·움직임·생활 지원

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Vận động Parkinson có thể đổi theo tác dụng thuốc; xác nhận điều dưỡng đảm bảo giờ thuốc. Bố trí ăn tắm vào lúc dễ vận động, có nghỉ. Không tự trễ giờ hay nghiền thuốc.

03

Khi chân như dính sàn, không thúc kéo; giúp dừng an toàn và giữ thăng bằng. Dùng nhịp đếm hay dấu sàn do phục hồi hướng dẫn. Quay rộng, không xoay gấp; dọn lối hẹp.

04

Từ giường ngồi lên chậm, kiểm tra chóng mặt rồi đứng có hỗ trợ. Không dựng đột ngột. Ăn theo hướng dẫn nuốt, đủ thời gian. Ghi và báo ho, chảy dãi, sụt cân hoặc táo bón kéo dài.

05

Báo ngay nếu đột nhiên khó cử động hơn, ngủ gà, lú lẫn. Không tự xử lý ngã, ảo giác hay nuốt xấu. Luyện kiểm tra giờ thuốc, chờ khi đông cứng, đứng chậm và dọn lối hẹp.

S07. 당뇨 환자·식사·피부·이상 징후

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 식사·검사·투약 일정의 이해와 전달 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 식사·일상

- 저혈당 의심

- 응급·고혈당 징후

- 발 관리·기록

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 점심을 거의 먹지 않은 환자가 평소와 다르게 반응하는 사례입니다. 섭취 사실과 발생 시간을 보고하는지 평가합니다. 인슐린 용량 조정이나 혈당 수치 해석을 독자적으로 하지 않습니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S07 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 식은땀·떨림·의식·식사량·발 피부입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

저혈당 의심·의식 변화·새 발 상처 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오전 11시 손 떨림과 식은땀, 어지럼을 호소함. 즉시 간호사를 불러 혈당 확인을 요청함. 아직 측정하지 않아 숫자는 기록하지 않음.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 식은땀에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S07. 당뇨 환자·식사·피부·이상 징후

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 식은땀·떨림·의식·식사량·발 피부를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 저혈당 의심·의식 변화·새 발 상처는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 식사·일상

식사·일상입니다. 식사 시간과 처방된 식이, 실제 먹은 양을 확인합니다. 식사를 거르거나 구토했으면 투약 전에 간호사에게 알려 조정 판단을 받습니다. 간병인이 인슐린·약 용량을 정하지 않습니다. 발과 발가락 사이의 상처·붉음·물집을 보고 맨발 보행이나 뜨거운 찜질은 피합니다.

03 / 저혈당 의심

저혈당 의심입니다. 식은땀, 떨림, 갑작스러운 배고픔·혼돈이 생기면 활동을 멈추고 즉시 간호사를 부릅니다. 혈당 확인과 처치는 병원 저혈당 절차에 따릅니다. 의식이 명료하고 안전하게 삼킬 수 있으며 지시가 있는 경우에만 지정된 빠른 당분 섭취를 보조하고 재확인을 받습니다.

04 / 응급·고혈당 징후

응급·고혈당 징후입니다. 의식 저하, 경련 또는 삼키기 어려움이 있으면 입으로 사탕·물·음식을 주지 않고 비상 호출합니다. 심한 갈증, 잦은 소변에 구토·복통·깊고 빠른 호흡·졸림이 동반돼도 즉시 알립니다. 혈당 숫자만 보며 기다리거나 약을 추가하지 않습니다.

05 / 발 관리·기록

발 관리·기록입니다. 씻은 발은 특히 발가락 사이를 말리고 신발 안 이물질을 확인합니다. 티눈·굳은살을 칼로 깎거나 상처 약을 임의로 바르지 않습니다. 식사량, 증상 시각, 측정된 혈당과 받은 조치를 기록합니다. 실습은 의식·삼킴 여부에 따라 입으로 주면 안 되는 상황을 구별합니다.

학습 메모

_____

_____

S07. 당뇨 환자·식사·피부·이상 징후

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Kiểm tra giờ ăn, chế độ và lượng đã ăn. Bỏ bữa, nôn: báo trước dùng thuốc để y tế quyết định. Không tự định insulin hay liều. Quan sát vết thương, đỏ, phồng rộp ở chân, kẽ; tránh chân trần và chườm nóng.

03

Vã mồ hôi, run, đói đột ngột, lú lẫn: dừng và gọi điều dưỡng ngay. Đo, xử trí theo quy trình hạ đường. Chỉ hỗ trợ đường nhanh chỉ định khi tỉnh, nuốt an toàn và có hướng dẫn, rồi được kiểm tra lại.

04

Giảm ý thức, co giật, khó nuốt: không cho kẹo, nước, thức ăn; gọi khẩn. Khát, tiểu nhiều kèm nôn, đau bụng, thở sâu nhanh, ngủ gà cũng báo ngay. Không chỉ chờ số đo hay thêm thuốc.

05

Sau rửa làm khô nhất là kẽ, kiểm tra vật lạ trong giày. Không cắt chai bằng dao hay tự bôi thuốc vết thương. Ghi ăn, thời điểm, đường đã đo và xử trí. Luyện phân biệt khi không được cho đường miệng theo ý thức, nuốt.

S08. 투석 환자·이동·치료 전후 돌봄

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 혈액투석·복막투석·가정혈액투석의 보조 범위를 구분한다.

- 전후 준비·생활지원·관찰·수치 기록을 사례로 수행한다.

- 출혈·혼탁 배액·복통·의식 변화에 즉시 보고·비상 대응한다.

세부 교육내용

관찰 → 기록 → 보고 / 투석 전 준비 / 투석 후 일상 / 출혈·감염 경고 / 기록·실습 / 교대 합계·누락·보고 / 혈액투석·복막투석·자가투석 구분 / 혈액투석 전·이동 준비 / 혈액투석 중·귀실 후 / 복막투석·교환 환경 보조 / 복막투석·배액·출구 관찰 / 가정혈액투석·비상계획 / 투석별 수치·인계 사례

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 투석에서 돌아온 환자의 이동과 관찰 기록입니다. 치료 일정, 개별 제한, 지원 후 반응, 보고 대상을 빠뜨리지 않는지 평가합니다. 정상과 이상을 혼자 판단해 치료 일정을 바꾸지 않습니다. 실습용 눈금컵과 저울로 제공량·잔량·용기 무게를 확인하고 실측·추정·측정 불가를 구분해 기록하는 과제를 포함합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S08 관찰·기록·보고

1. 관찰

투석 방식, 전후 어지럼·피로·통증, 혈관통로 출혈과 복막투석 배액의 양·맑기, 복통·발열·출구 상태를 평소와 비교합니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

혈액투석의 출혈·흉통·심한 어지럼, 복막투석의 혼탁 배액·복통·누출은 즉시 투석 담당팀에 보고합니다. 큰 출혈·의식 변화는 비상 호출합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 5시 투석 후 침상에 앉을 때 어지럽다고 말함. 혼자 걷지 않도록 돕고 간호사에게 확인을 요청함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 투석 후 어지럼에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S08 섭취·배설 수치 기록 실습

모두 가상 계산 예시이며 정상량이나 환자별 목표가 아닙니다. 측정 방법·주기·보고 기준은 해당 병원 지시를 따릅니다. 식품용과 배설물용 도구를 구분합니다.

시간/구간	항목	측정 내역	기록할 수치	상태·측정 방법
08:00	물	제공 200 mL / 남음 80 mL	120 mL 섭취	눈금 실측·흘림 없음
08:10	죽	제공 200 g / 남음 50 g	150 g 섭취	용기 무게 제외·흘림 없음
08:00–10:00	소변	전용 눈금 용기	250 mL 배출	연한 노란색·통증 없음
10:20	대변	총 180 g / 용기 40 g	140 g / 1회	갈색·형성변·혈액 없음
12:00	기저귀 소변	젖음 280 g / 마름 30 g	약 250 mL 추정	소변만·누출 없음·병원 환산법
14:00	혼합 기저귀	소변·대변이 섞임	소변량 측정 불가	0 mL로 입력하지 않음

작성 연습

환자 / 날짜 / 시간·구간 / 음식·배설 종류 / 제공량 / 남은 양 / 흘린 양 / 실제량 / 단위 / 실측·추정·불가 / 색·형태·증상 / 작성자 / 보고 시각·대상 / 받은 지시

_____

_____

_____

S08. 투석 환자·이동·치료 전후 돌봄

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 투석 후 어지럼·안색·혈관통로 출혈를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 지속 출혈·발열·실신·심한 숨참는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 투석 전 준비

투석 전 준비입니다. 투석 일정, 이동 도움, 수분·식이 제한, 혈관통로 위치를 인계받습니다. 동정맥루가 있는 팔을 조이는 옷·끈·혈압 측정을 피하도록 표시와 지시를 확인합니다. 카테터 드레싱을 젖게 하거나 열지 않습니다. 체중과 섭취량은 병원 측정 계획에 맞춰 기록을 돕습니다.

03 / 투석 후 일상

투석 후 일상입니다. 귀실 후 피로, 어지럼, 오심과 천자 부위 출혈을 확인합니다. 곧바로 혼자 걷게 하지 말고 천천히 일어나도록 돕습니다. 어지럽다고 물을 마음대로 많이 주지 말고 간호사에게 알립니다. 쉬는 시간과 필요한 배설·식사를 조정합니다.

04 / 출혈·감염 경고

출혈·감염 경고입니다. 혈관통로에서 많은 피가 나면 즉시 비상 호출하고 깨끗한 거즈로 출혈 지점을 직접 압박하며 도움을 기다립니다. 계속 확인하느라 압박을 반복 풀지 않습니다. 붓기·붉음·통증·열감·발열이나 오한도 즉시 보고하며 관을 만지거나 다시 연결하지 않습니다.

05 / 기록·실습

기록·실습입니다. 이동 시각, 투석 후 증상, 출혈 유무와 섭취량을 전달합니다. 갑작스러운 흉통·심한 숨참·실신은 비상 대응합니다. 실습은 보호할 팔 확인, 수분 제한 인계, 귀실 후 관찰과 출혈 상황의 도움 요청·직접 압박을 감독하에 연습합니다.

06 / 교대 합계·누락·보고

교대 합계·누락·보고입니다. 행마다 환자, 날짜·시각과 작성자를 확인하고 섭취·배출 직후 기록합니다. 교대나 병원이 정한 하루 구간에 밀리리터 항목끼리 합산합니다. 소변, 측정한 구토·액상 배출은 구분하고 음식·대변의 그램 기록과 섞지 않습니다. 측정하지 못함은 영이 아니므로 이유와 누락을 전달합니다. 수분 균형의 의미와 제한량 조정은 의료진이 판단합니다. 갑작스러운 소변 감소, 혈액, 검은 변, 반복 구토·설사는 합계 시간을 기다리지 말고 보고합니다.

07 / 혈액투석·복막투석·자가투석 구분

혈액투석·복막투석·자가투석 구분입니다. 혈액투석은 혈관통로를 통해 기계로 혈액을 정화하고, 복막투석은 배 안에 넣은 투석액을 교환하는 방식입니다. 자가투석은 집에서 하는 복막투석이나 가정혈액투석을 가리킬 수 있으므로 인계 때 실제 방식을 확인합니다. 일반 간병 교육만으로 투석을 시행할 수 있는 것은 아닙니다. 환자·지원자의 별도 교육과 숙련 확인, 담당 투석팀의 계획이 필요합니다.

08 / 혈액투석 전·이동 준비

혈액투석 전·이동 준비입니다. 일정과 이동 인원, 혈관통로 위치, 금식 여부·식사·투약 지시를 인계받습니다. 혈압과 체중은 지정된 담당자가 측정한 값과 시각을 확인해 기록합니다. 스스로 약을 빼거나 물을 더 마시게 하지 않습니다. 휠체어 브레이크와 관 당김을 살피고 투석실에 최근 어지럼·출혈·발열·섭취 변화와 낙상 정보를 전달합니다.

09 / 혈액투석 중·귀실 후

혈액투석 중·귀실 후입니다. 투석 중 식은땀, 어지럼, 구역, 쥐남·흉통·숨참을 호소하면 즉시 투석실 의료진에게 알립니다. 기계나 경보를 조작하지 않습니다. 귀실 후 천자부위 출혈과 피로를 확인하고 앉기·서기를 천천히 보조합니다. 허용된 휴식 후 이동하며 출혈이나 심한 증상이 지속되면 다시 호출합니다. 물·소금·약을 임의로 주어 해결하지 않습니다.

10 / 복막투석·교환 환경 보조

복막투석·교환 환경 보조입니다. 수동 교환인지 야간 자동복막투석인지 계획을 확인합니다. 간병인은 담당팀 지시에 따라 청결한 공간과 필요한 물품, 손 위생과 마스크 등 감염 예방을 보조합니다. 연결부에 손대거나 교환 도중 불필요하게 방해하지 않습니다. 투석액 종류·농도·양·가온과 연결·분리는 훈련·권한을 갖춘 담당자가 정해진 절차대로 시행합니다. 전자레인지 등 임의의 가열 방법을 쓰지 않습니다.

11 / 복막투석·배액·출구 관찰

복막투석·배액·출구 관찰입니다. 배액의 양과 맑기·색, 복통, 발열·오한과 관 출구의 붉음·분비물을 관찰합니다. 배액이 뿌옇거나 복통이 생기면 열이 없어도 즉시 투석 담당팀에 알립니다. 배액백은 확인·검체 지시를 받기 전 임의로 버리지 않습니다. 관 누출·분리·오염이 의심되면 즉시 연락하고 임의로 다시 연결·세척하지 않습니다.

12 / 가정혈액투석·비상계획

가정혈액투석·비상계획입니다. 가정혈액투석은 전문팀 교육과 환경 점검, 비상 연락·중단 계획이 마련된 경우에 수행됩니다. 일반 간병인은 정해진 관찰과 생활지원만 담당합니다. 바늘 삽입·제거, 혈액회로 연결·재연결, 기계 설정은 대신하지 않습니다. 경보·혈액 누출·바늘 이탈·의식 변화는 즉시 훈련된 담당자와 비상 지원에 알리고, 교육받은 안전 절차를 따릅니다.

13 / 투석별 수치·인계 사례

투석별 수치·인계 사례입니다. 혈액투석 전후 체중은 같은 단위 킬로그램으로, 수분 섭취와 소변은 밀리리터로 기록합니다. 기계의 제거량은 의료진 확인값을 사용하며 체중 차이를 임의로 같은 수치로 옮기지 않습니다. 복막투석은 회차별 실제 주입량과 배액량, 시각·혼탁·통증을 따로 적습니다. 예를 들어 주입 이천, 배액 이천삼백 밀리리터의 차이 삼백은 해당 교환의 차이이며 소변량이나 하루 전체 수분 균형이 아닙니다.

학습 메모

_____

_____

S08. 투석 환자·이동·치료 전후 돌봄

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Bàn giao lịch, di chuyển, giới hạn nước ăn và đường mạch. Theo chỉ dẫn tránh áo dây siết, đo huyết áp ở tay cầu nối. Không làm ướt, mở băng catheter. Hỗ trợ ghi cân, lượng vào theo kế hoạch đo.

03

Sau về phòng kiểm tra mệt, chóng mặt, buồn nôn, máu chỗ chọc. Không để đi một mình ngay; giúp đứng chậm. Không tự cho nhiều nước vì chóng mặt, báo điều dưỡng. Điều chỉnh nghỉ, vệ sinh và ăn.

04

Chảy máu nhiều từ đường mạch: gọi khẩn, dùng gạc sạch ép trực tiếp điểm chảy và chờ hỗ trợ. Không liên tục nhấc kiểm tra. Sưng đỏ đau nóng, sốt rét run cũng báo ngay; không thao tác hay nối lại ống.

05

Báo giờ chuyển, triệu chứng sau lọc, có máu không, lượng vào. Đau ngực, khó thở nặng, ngất đột ngột: cấp cứu. Luyện xác định tay bảo vệ, giới hạn nước, quan sát sau về và gọi, ép trực tiếp dưới giám sát.

06

Xác nhận người, ngày giờ, người ghi; ghi ngay sau ăn uống, bài tiết. Cộng các mục mL theo ca hay khoảng ngày viện quy định. Tách tiểu, nôn đo được, dịch lỏng; không trộn với g thức ăn, phân. Không đo được không phải số 0; bàn giao lý do, thiếu. Y tế đánh giá cân bằng và điều chỉnh. Tiểu giảm đột ngột, máu, phân đen, nôn tiêu chảy lặp phải báo ngay.

07

Chạy thận nhân tạo lọc máu bằng máy qua đường mạch; thẩm phân phúc mạc trao đổi dịch trong bụng. Tự lọc tại nhà có thể là phúc mạc hay chạy thận tại nhà, phải xác nhận phương thức. Khóa chăm sóc chung không đủ để thực hiện; cần đào tạo, xác nhận năng lực và kế hoạch nhóm lọc.

08

Bàn giao lịch, người chuyển, đường mạch, nhịn ăn, ăn và thuốc. Ghi cân, huyết áp, giờ từ người đo được chỉ định. Không tự bỏ thuốc hoặc cho uống thêm. Kiểm tra khóa xe, kéo ống; báo phòng lọc chóng mặt, máu, sốt, ăn uống thay đổi, ngã.

09

Trong lọc nếu vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút, đau ngực, khó thở thì báo ngay nhân viên lọc. Không chỉnh máy, báo động. Về phòng kiểm tra chảy máu, mệt, giúp ngồi đứng chậm, nghỉ theo phép. Còn chảy máu hay triệu chứng nặng gọi lại, không tự xử bằng nước, muối, thuốc.

10

Xác nhận đổi tay hay máy ban đêm. Hỗ trợ nơi sạch, đồ dùng, vệ sinh tay, khẩu trang theo nhóm phụ trách. Không chạm đầu nối, làm gián đoạn không cần. Loại, nồng độ, lượng, làm ấm, nối tháo do người được đào tạo và có quyền thực hiện theo quy trình. Không tự dùng lò vi sóng làm nóng.

11

Quan sát lượng, độ trong, màu dịch ra, đau bụng, sốt rét run, đỏ hay dịch chỗ ra ống. Dịch đục hoặc đau bụng dù không sốt phải báo nhóm lọc ngay. Không tự bỏ túi trước hướng dẫn kiểm tra, mẫu. Nghi rò, tuột, nhiễm bẩn thì liên hệ ngay, không tự nối rửa.

12

Chạy thận tại nhà cần đào tạo chuyên môn, kiểm tra môi trường, kế hoạch dừng và gọi khẩn. Người chăm sóc chung chỉ quan sát, hỗ trợ đã phân công; không thay chọc rút kim, nối lại mạch, cài máy. Báo động, rò máu, tuột kim, đổi ý thức: báo ngay người đã đào tạo và cấp cứu, theo quy trình an toàn đã học.

13

Ghi cân trước sau chạy thận bằng kg, uống và tiểu bằng mL. Lượng máy lấy ra dùng số y tế xác nhận, không tự đổi chênh cân thành số đó. Phúc mạc ghi từng lần thực vào, ra, giờ, đục, đau. Ví dụ vào 2000 ra 2300 mL chênh 300 chỉ là chênh lần đổi, không phải tiểu hay cân bằng cả ngày.

S09. 암 환자: 간암·뇌암·췌장암·대장암·폐암 등

전문교육 | 계획 10시간 | 교안

설명·시연 3시간 / 연습·실습 5시간 / 평가·피드백 2시간

학습 목표

- 공통 돌봄: 피로·통증·영양·감염예방 2시간 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

치료 단계별 공통 돌봄 / 항암 중 주의 / 간암 환자 / 뇌암·뇌종양 환자 / 췌장암 환자 / 대장암·장루 환자 / 폐암 환자 / 통증·구강·피부 지원 / 완화 단계·사례 평가

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 통증약, 항암제, 산소나 장루 처치를 독자적으로 조정하지 않습니다. 갑작스러운 의식 변화, 심한 호흡곤란이나 큰 출혈은 즉시 비상 연락합니다. 사례 평가에서는 다섯 암종의 관찰 항목과 보고 대상을 구분해 인수인계합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S09 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 통증·식사·구토·변·발열·치료 부작용입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

발열·오한·새 혼돈·지속 구토·출혈 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 4시 항암치료 중 오한을 호소함. 간호사에게 즉시 알리고 측정한 체온과 측정 시각은 담당자 확인 후 기록함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 통증에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S09. 암 환자: 간암·뇌암·췌장암·대장암·폐암 등

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 통증·식사·구토·변·발열·치료 부작용를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 발열·오한·새 혼돈·지속 구토·출혈는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 치료 단계별 공통 돌봄

치료 단계별 공통 돌봄입니다. 암 환자의 도움 수준은 병기 숫자만으로 정하지 않습니다. 수술 후에는 상처·배액관·통증과 이동 계획, 약물·방사선 치료 중에는 섭취·피로·감염 징후, 진행성 단계에는 통증·호흡·편안함과 환자 선호를 확인합니다. 같은 병기라도 기능과 치료에 따라 계획이 다릅니다.

03 / 항암 중 주의

항암 중 주의입니다. 손 위생과 구강 청결을 돕고 아픈 방문객 접촉을 피합니다. 발열은 병원 연락 기준을 따르며 항암 중 삼십팔 도 이상이거나 오한이 있으면 즉시 보고합니다. 임의의 해열제·건강식품으로 기다리지 않습니다. 지속 구토, 설사, 출혈과 먹지 못함은 횟수·양을 기록해 전달합니다.

04 / 간암 환자

간암 환자입니다. 복부가 불러 옷이 조이거나 식사·호흡이 불편한지 확인합니다. 편안한 자세와 소량씩 먹는 식사를 지원하되 수분·염분 제한은 처방대로 합니다. 새 혼돈·심한 졸림, 피 토함·검은 변은 즉시 보고합니다. 배를 강하게 누르거나 복수를 해결하려고 민간요법을 쓰지 않습니다.

05 / 뇌암·뇌종양 환자

뇌암·뇌종양 환자입니다. 기억·말·팔다리 힘·균형의 변화를 관찰하고 이동 시 곁에서 정해진 도움을 제공합니다. 새로운 심한 두통, 반복 구토, 의식 변화나 경련은 즉시 의료진을 부릅니다. 경련 때 주변을 치우고 머리를 보호하며 입에 물건을 넣거나 몸을 억누르지 않습니다.

06 / 췌장암 환자

췌장암 환자입니다. 식욕·섭취량, 복부·등 통증과 변의 변화를 기록합니다. 적은 양을 나누어 제공하고 필요한 영양 보조는 영양사 지시를 확인합니다. 소화효소제나 인슐린은 담당자가 정한 식사와 투약 계획을 따르며 임의 조절하지 않습니다. 심한 통증·구토·발열은 바로 보고합니다.

07 / 대장암·장루 환자

대장암·장루 환자입니다. 수술 후 식이와 배변 계획을 확인하고 대변·장루 배출량, 피부와 누출을 관찰합니다. 교육받은 범위에서 주머니가 너무 차기 전에 비우기를 돕되 장루에 관을 넣거나 세척하지 않습니다. 복부 팽만·구토와 배출 중단, 심한 출혈이나 장루 색 변화는 즉시 보고합니다.

08 / 폐암 환자

폐암 환자입니다. 숨참 때 활동을 쉬고 허용된 앉은 자세와 팔 지지를 돕습니다. 세면·식사·이동 사이에 휴식을 넣고 산소 유량·흉관은 조작하지 않습니다. 갑작스러운 숨참, 흉통·객혈은 즉시 비상 평가를 요청합니다. 네뷸라이저는 처방된 경우에만 사용하며 전문교육 폐질환 과목의 전후 점검을 따릅니다.

09 / 통증·구강·피부 지원

통증·구강·피부 지원입니다. 통증 위치와 강도, 언제 심해지는지 물어 기록하고 의료진에게 전달합니다. 부드러운 구강 위생, 자극 적은 식사와 편한 자세를 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 방사선 조사 부위에 임의의 연고·찜질을 하지 않습니다. 진통제를 임의로 늘리거나 참으라고 하지 않습니다.

10 / 완화 단계·사례 평가

완화 단계·사례 평가입니다. 피곤하면 짧은 돌봄과 휴식으로 나누고 환자가 원하는 활동을 우선합니다. 식사를 강요하지 않으며 불안과 가족의 질문을 듣고 담당자에게 연결합니다. 사례 평가는 간암의 새 혼돈, 뇌종양 경련, 장루 배출 중단, 폐암의 새 숨참에서 무엇을 중단하고 누구를 부를지 설명하게 합니다.

학습 메모

_____

_____

S09. 암 환자: 간암·뇌암·췌장암·대장암·폐암 등

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Không quyết định hỗ trợ chỉ bằng số giai đoạn ung thư. Sau mổ: vết thương, dẫn lưu, đau, đi lại; khi thuốc xạ trị: ăn, mệt, nhiễm trùng; tiến triển: đau, thở, thoải mái, mong muốn. Cùng giai đoạn vẫn cần kế hoạch khác.

03

Hỗ trợ vệ sinh tay, miệng; tránh khách đang bệnh. Theo ngưỡng báo sốt của viện; hóa trị có sốt từ 38 độ hoặc rét run thì báo ngay. Không tự hạ sốt hay dùng bổ sung rồi chờ. Ghi số lần, lượng nôn tiêu chảy, máu và không ăn được.

04

Hỏi bụng căng làm chật áo, khó ăn thở không. Hỗ trợ tư thế, bữa nhỏ; hạn chế nước muối theo chỉ định. Lú lẫn, ngủ gà mới, nôn máu, phân đen: báo ngay. Không ép bụng hay dùng mẹo chữa cổ trướng.

05

Quan sát trí nhớ, nói, lực tay chân, thăng bằng; hỗ trợ chuyển theo kế hoạch. Đau đầu nặng mới, nôn lặp, đổi ý thức, co giật: gọi ngay. Khi co giật dọn quanh, bảo vệ đầu, không đưa đồ vào miệng hoặc ghì.

06

Ghi ăn, đau bụng lưng, thay đổi phân. Chia bữa nhỏ, bổ sung theo chuyên viên dinh dưỡng. Men tiêu hóa, insulin theo kế hoạch thuốc ăn của người phụ trách, không tự chỉnh. Đau nhiều, nôn, sốt: báo ngay.

07

Kiểm tra ăn và bài tiết sau mổ, quan sát lượng phân lỗ mở, da, rò. Trong phạm vi được học giúp xả trước quá đầy; không đưa ống hay bơm rửa lỗ mở. Chướng, nôn kèm ngừng ra, máu nhiều, đổi màu lỗ mở: báo ngay.

08

Khó thở: nghỉ, giúp ngồi và đỡ tay được phép. Nghỉ giữa rửa ăn đi; không chỉnh oxy hay dẫn lưu. Khó thở đột ngột, đau ngực, ho máu: gọi đánh giá khẩn. Khí dung chỉ khi kê đơn, theo bài chăm sóc phổi.

09

Hỏi, ghi vị trí mức đau, khi tăng và báo y tế. Hỗ trợ vệ sinh miệng nhẹ, ăn ít kích thích, tư thế riêng. Không tự bôi, chườm vùng xạ trị; không tăng thuốc hay bảo chịu đau.

10

Mệt thì chia chăm sóc ngắn và nghỉ, ưu tiên điều mong muốn. Không ép ăn, nghe lo âu và câu hỏi gia đình, nối với người phụ trách. Đánh giá lú lẫn mới ở ung thư gan, co giật, lỗ mở ngừng ra, khó thở mới: dừng gì, gọi ai.

S10. 호스피스 환자·완화적 돌봄·가족 지원

전문교육 | 계획 6시간 | 교안

설명·시연 2시간 / 연습·실습 3시간 / 평가·피드백 1시간

학습 목표

- 환자 의사·문화·종교·돌봄 목표 존중 내용을 설명한다.

- 개별 지시 확인·안전한 지원·관찰 보고를 모의 상황에서 수행한다.

세부 교육내용

- 목표와 선호 확인

- 입안·식사 돌봄

- 통증·숨참·체위

- 가족·급변 대응

준비물: 해당 병원의 개별 돌봄계획 예시, 상황 카드, 교육용 모형·물품, 관찰·보고 평가표

수업 운영과 활동

도입: 학습자의 사전 경험과 어휘를 확인합니다. 전개: 강사의 설명·시연 후 활동을 여러 차시에 걸쳐 반복하고 피드백합니다. 정리: 이해와 수행을 확인하고 보충 계획을 기록합니다.

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다. 준비→수행→관찰→중단·보고→마무리를 모형과 역할극으로 반복합니다. 주제별 설명 후 강사 시연, 모형 실습, 역할 교대, 사례 보고와 재평가를 진행합니다. 실습은 환자가 쉬고 싶어 하는데 가족이 식사를 권하는 상황입니다. 편을 들거나 치료 결정을 대신하지 않고 환자의 뜻을 듣고 담당팀과 연결합니다. 사망 판단이나 통보를 독자적으로 하지 않는 역할 경계도 확인합니다.

확인 문제와 해설

돌봄 전 확인 사항, 수행 순서, 중단·보고해야 할 상황을 이 과목의 사례로 설명하고 모형에서 시연하세요.

해설: 개별 지시와 동의 확인, 과목별 돌봄 순서, 위험 징후에 따른 즉시 중단·보고, 관찰 기록을 설명합니다. 약·기구·치료를 임의로 조정하면 재교육합니다.

강사 기록

교육일 / 강사 / 학습자 / 실제 이수시간: _____

수행 평가 / 보충 내용 / 재평가 / 확인: _____

S10 관찰·기록·보고

1. 관찰

관찰 항목은 표정·신음·안절부절·입안 건조·선호입니다. 평소 상태와 비교합니다. 환자의 말과 직접 본 사실을 구분하고, 임의로 진단하지 않습니다.

2. 기록

발생 날짜·시각, 당시 활동, 관찰 사실과 환자의 말, 실제로 측정한 값·시각, 시행한 도움, 보고 대상·시각, 받은 지시와 이후 반응을 적습니다. 측정하지 않은 수치는 쓰지 않습니다. 섭취·배설은 시각, 음식·음료 종류, 실제 섭취·배출량과 단위(mL 또는 g), 색·형태, 실측·추정·측정 불가를 구분합니다. 상세 계량은 G02·G03·S02에서 연습합니다.

3. 보고

조절되지 않는 통증·숨참·급격한 변화 등의 변화가 있으면 간호사에게 바로 알립니다. 환자·장소 → 언제 무엇이 달라졌는지 → 한 도움과 현재 상태 → 확인 요청 순서로 말하고 지시를 되읽어 확인합니다.

응급이면 호출 먼저

심한 호흡곤란, 의식 저하, 새 마비, 멎지 않는 큰 출혈은 기록보다 비상 호출이 먼저입니다. 담당자 응답이 없으면 병원 비상 연락체계로 즉시 단계 상향합니다.

가상 사례 기록 예시

오후 8시 체위변경 때 얼굴을 찡그리고 신음함. 움직임을 멈추고 편안히 지지한 뒤 담당팀에 통증 평가를 요청함.

보고 말하기

"담당 간호사님, ○○병실 ○○환자입니다. 표정에 평소와 다른 변화가 있습니다. 발생 시각·관찰 사실·시행한 도움을 말씀드리겠습니다. 지금 확인해 주세요."

말벗·정서지원

환자의 말·표정·불안·외로움을 살피고 "많이 힘드시겠어요. 어떤 도움이 필요하세요?"라고 묻습니다. 대화를 강요하거나 회복을 보장하지 않습니다. 동의받은 경청·활동과 환자의 반응을 기록하고 지속되는 불안·수면·식사 변화는 간호사에게 전달합니다. 구체적인 말벗 대화와 위기 대응은 G01 강의에서 연습합니다.

일상생활지원

식사·배설·위생·옷 입기·이동·수면에서 환자가 스스로 할 수 있는 부분을 확인하고 필요한 만큼 지원합니다. 수행 능력, 제공한 도움, 통증·피로와 평소와의 차이를 기록·보고합니다.

개인활동지원

환자가 선택한 취미·가족 연락·허용된 산책과 진료 동행을 개별 계획에 맞춰 돕습니다. 동의·이동 안전·휴식을 확인하고 활동 내용, 참여 반응과 중단 이유를 남깁니다. 자세한 방법은 G01 강의에서 다룹니다.

역할극 평가

2인 1조로 한 명은 간병인, 한 명은 간호사 역할을 맡습니다. 사실 관찰, 시간 기록, 핵심 보고, 지시 재확인을 평가합니다. 응급 사례는 메모보다 호출을 먼저 해야 통과합니다.

기록 양식

날짜·시각 / 환자·장소 / 당시 활동: _____

직접 본 사실·환자의 말 / 측정값·측정 시각: _____

시행한 도움 / 보고 대상·시각: _____

받은 지시·재확인 / 이후 반응·추가 보고: _____

S10. 호스피스 환자·완화적 돌봄·가족 지원

한국어 강의내용 | 단계별 돌봄 원고

의료진·실습강사 검토용 초안. 실제 환자에게는 병원의 업무분장과 개별 처방·돌봄계획을 적용합니다. 강의 영상은 감독 실습을 대체하지 않습니다.

01 / 관찰 → 기록 → 보고

관찰, 기록, 보고가 이 과목의 기본입니다. 표정·신음·안절부절·입안 건조·선호를 평소와 비교해 살핍니다. 언제 무엇을 하다가 어떤 변화가 있었고 어떤 도움을 주었는지 기록합니다. 조절되지 않는 통증·숨참·급격한 변화는 즉시 간호사에게 보고합니다. 심한 호흡곤란이나 의식 변화는 기록보다 비상 호출을 먼저 합니다.

02 / 목표와 선호 확인

목표와 선호 확인입니다. 호스피스 돌봄은 편안함과 환자의 뜻을 중심으로 합니다. 치료팀이 정한 통증·호흡곤란 대응과 연락 방법을 인계받고 환자가 원하는 자세, 음악, 면회와 종교적 선호를 묻습니다. 연명의료 관련 결정은 간병인이 임의로 판단하지 않고 의료진이 확인한 계획을 따릅니다.

03 / 입안·식사 돌봄

입안·식사 돌봄입니다. 입이 마르면 간호사가 가르친 방법으로 입안과 입술을 촉촉하게 돌봅니다. 깨어 있고 안전하게 삼킬 때 원하는 음식을 허용된 형태로 조금씩 제공합니다. 졸리거나 삼키지 못하면 물을 붓거나 억지로 먹이지 말고 구강 돌봄 방법을 다시 확인합니다.

04 / 통증·숨참·체위

통증·숨참·체위입니다. 표정 찡그림, 신음, 안절부절과 숨참을 보고하고 약물 판단은 의료진에게 맡깁니다. 허용되는 편한 자세로 베개를 받치고 소음과 불필요한 자극을 줄입니다. 체위변경은 피부 보호와 통증·휴식을 함께 고려한 계획에 따릅니다. 산소나 진통제 용량을 바꾸지 않습니다.

05 / 가족·급변 대응

가족·급변 대응입니다. 가족이 도울 수 있는 손잡기와 조용한 대화를 안내하고 예후를 단정하지 않습니다. 급격한 변화나 조절되지 않는 통증은 즉시 담당팀에 연락합니다. 응급 상황은 의료진이 확인한 치료목표와 병원 절차를 따르며 혼자 중단 여부를 결정하지 않습니다. 돌봄 반응과 가족 요청을 인계합니다.

학습 메모

_____

_____

S10. 호스피스 환자·완화적 돌봄·가족 지원

베트남어 강의 번역

Nội dung tiếng Việt

교육 운영 전 강사·통역 담당자의 검토를 위한 번역본입니다.

01

Quan sát, ghi chép, báo cáo là nền tảng. So sánh với thường ngày. Ghi khi nào, đang làm gì, thay đổi thấy được và hỗ trợ đã làm. Báo thay đổi cho điều dưỡng, xác nhận lại chỉ dẫn. Khó thở nặng hay đổi ý thức: gọi khẩn trước khi ghi.

02

Chăm sóc hospice đặt thoải mái, ý muốn ở trung tâm. Bàn giao kế hoạch đau, khó thở, liên hệ; hỏi tư thế, nhạc, thăm, tín ngưỡng. Không tự quyết định điều trị duy trì sự sống, theo kế hoạch đã được y tế xác nhận.

03

Khô miệng: chăm ẩm miệng môi theo điều dưỡng. Tỉnh và nuốt an toàn thì cho ít món muốn ở dạng được phép. Buồn ngủ, không nuốt được: không đổ nước hay ép ăn, hỏi lại cách chăm miệng.

04

Báo nhăn mặt, rên, bồn chồn, khó thở; thuốc do y tế quyết định. Đỡ gối theo tư thế thoải mái được phép, giảm ồn. Đổi tư thế theo kế hoạch cân bằng da, đau, nghỉ. Không đổi oxy hay giảm đau.

05

Hướng dẫn gia đình nắm tay, nói yên, không tự kết luận tiên lượng. Thay đổi nhanh hoặc đau không kiểm soát: liên hệ nhóm ngay. Cấp cứu theo mục tiêu y tế đã xác nhận, quy trình; không tự quyết định ngừng. Bàn giao phản ứng và yêu cầu gia đình.

자료의 기준과 운영 안내

기존 한국어 교육과 TOPIK II 3급 목표를 유지하고, 사용자가 요청한 돌봄 유형에 따라 직무교육 120시간을 일반교육 48시간·전문교육 72시간으로 재편했습니다. 일반교육의 안전 수행을 확인한 뒤 전문교육을 진행합니다. 실제 배치 전에는 해당 병원의 업무분장·개별 계획과 강사 평가를 확인합니다. 기존 수강생의 출석·이수 기록은 소급 변경하지 않습니다.

이수 관리

출석, 실제 교육시간, 평가 결과와 강사 확인을 과목별로 기록합니다. 미이수 과목은 보충교육과 재평가를 진행합니다. 실제 TOPIK II 시험 성적과 과정 수료는 별개로 관리합니다.

영상·자막

특정인을 모델로 하지 않은 실사형 한국인 AI 강사 이미지와 한국어 여성 합성음성으로 제작했습니다. 아나운서식 낭독을 위해 속도와 쉼을 조정했으며 특정인의 음성을 복제하지 않았습니다. 입 모양 동기화 영상은 아닙니다. 베트남어·한국어 자막을 선택할 수 있습니다. 자막은 문단 단위 음성에 맞춘 검토용이며, 실제 교육 전 번역과 문장별 시점을 확인합니다.

참고 자료

국립국제교육원 · 한국어능력시험 안내

https://www.niied.go.kr/web/niied/contents/niied_topik

한국어기초사전 · 베트남어

https://krdict.korean.go.kr/vie/mainAction

환자안전 보고학습시스템 · 노인 낙상 주의경보

https://www.kops.or.kr/portal/aam/atent/atentAlarmCntrmsrDetail.do?atentAlarmNo=474

질병관리청 · 의료관련감염 관리

https://www.kdca.go.kr/kdca/3022/subview.do

NHS · 경관영양 개요

https://www.nhs.uk/conditions/malnutrition/treatment/

NHS · 유치도뇨관 생활 관리

https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/urinary-catheters/living-with/

NHS · 호흡곤란

https://www.nhs.uk/symptoms/shortness-of-breath/

NHS · 뇌졸중 증상

https://www.nhs.uk/conditions/stroke/symptoms/

NHS · 파킨슨병 증상

https://www.nhs.uk/conditions/parkinsons-disease/symptoms/

NHS · 저혈당

https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-sugar-hypoglycaemia/

CUH NHS · 투석 도관 관리

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/how-to-take-care-of-your-dialysis-catheter/

미국 국립암연구소 · 암 환자 돌봄

https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/family-friends/family-caregivers-pdq

미국 국립암연구소 · 완화의료

https://www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/care-choices/palliative-care-fact-sheet

NHS · 폐렴

https://www.nhs.uk/conditions/pneumonia/

NHS · 폐색전증

https://www.nhs.uk/conditions/pulmonary-embolism/

MSD · 폐색전증과 폐경색 구분

https://www.msdmanuals.com/home/lung-and-airway-disorders/pulmonary-embolism/pulmonary-embolism-pe

CUH · 호흡곤란 완화 자세

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/leaflet-4-positions-to-ease-breathlessness/

Kent NHS · 네뷸라이저 사용

https://www.kentcht.nhs.uk/leaflet/using-your-nebuliser/

CUH · 분비물 관리용 네뷸라이저

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/saline-nebulisers-for-secretion-management/

Cancer Research UK · 폐암 호흡곤란 돌봄

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/living-with/coping-with-breathlessness

CDC · 항암치료 중 발열

https://www.cdc.gov/cancer-preventing-infections/patients/fever.html

NCI · 치료 중 감염

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/infection

CUH · 경관영양 자세

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/tube-feeding-at-home/

NHS · 치매 의사소통

https://www.nhs.uk/conditions/dementia/living-with-dementia/communication/

Parkinson's UK · 동결 현상

https://www.parkinsons.org.uk/information/symptoms/motor/freezing

NHS · 투석 합병증

https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/dialysis/complications/

Leeds NHS · 임종기 식사·구강 돌봄

https://leedscommunityhealthcare.nhs.uk/our-services-a-z/adults-speech-and-language-therapy-2/care-home-guidance/eating-and-drinking-at-the-end-of-life/

NHS · 압박손상 예방

https://www.nhs.uk/conditions/pressure-sores/

NHS · 경청과 정서지원

https://www.nhs.uk/every-mind-matters/supporting-others/helping-others/

NHS · 성인 입원환자 수분 균형 기록

https://www.nhsprofessionals.nhs.uk/-/media/lts-media/trusts/northern-care-alliance/ncame01623v12hydrationandfluidbalanceforadultinpatientareas.pdf

Hull NHS · 음식·음료 기록

https://www.hey.nhs.uk/patient-leaflet/renal-food-diary-providing-information-on-your-usual-diet-for-your-nutritional-care/

NHS · 음식·수분 기록표

https://nwknowledgenow.nhs.uk/wp-content/uploads/2024/03/Food-and-Fluid-Record-Chart-for-Care-Homes.pdf

NHS · 혈액투석과 복막투석

https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/dialysis/how-its-done/

CUH · 복막투석 복막염 경고

https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/peritoneal-dialysis-pd-peritonitis-information/

NKF · 가정 투석 준비와 교육

https://www.kidney.org/kidney-topics/preparing-home-dialysis